BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

RIS CHACHAPOYAS

Semana Epidemiológica (del 21 de junio al 27 de junio de 2026)



DIRECTOR DE LA RIS CHACHAPOYAS
Mg. Clyde Cowan Muñoz Vargas

RESPONSABLE DE SALUD PUBLICA
Lic. Enf. Marly Asunta Zumaeta Villavicencio

RESPONSABLE DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA
Lic. Enf. Lith Mariela Malqui Zuta

EQUIPO TÉCNICO DE EPIDEMIOLOGÍA
Téc. Lab. Silvio Camilo Pariachi Cadenas
Téc. Enf. Milagros Montoya Rojas

APOYO OFICINA DE CC.RR.PP.
Téc. Comp. Marco A. Trigoso Chota

SE 25



Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | Dirección Regional de Salud | Red Integrada de Salud Chachapoyas

Presentación



La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la Epidemiología como "el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos (en particular de enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud".

El mundo actual, cada vez con mayor velocidad está expuestos a la propagación de los riesgos y amenazas de salud pública, como consecuencia de los tiempos de globalización en que vivimos, cada vez con mayor volumen y rapidez en el desplazamiento mundial de personas, incluyendo el fenómeno de la migración internacional. Esto trae como consecuencia la aparición de pandemias con mayor frecuencia, emergencia de nuevas enfermedades y reemergencia de enfermedades.

Nuestro país no es ajeno a este fenómeno, solo en la última década hemos sido testigos de la introducción de enfermedades como chikungunya y zika, la reintroducción del sarampión, transmisión de la viruela de mono, introducción de la pandemia de la COVID-19. Además del reto que significa continuar luchando contra las enfermedades endémicas como dengue, malaria, tuberculosis, VIH/SIDA, carbunco, fiebre amarilla selvática, riesgo de rabia humana y de fiebre amarilla selvática, entre otras.

Estos retos actuales de salud pública, representan un desafío para el sistema de salud del país, que tienen la responsabilidad en desarrollar competencias en epidemiologia y salud pública para hacerles frente.

La Oficina de Epidemiología de Epidemiología, es la Oficina de la Red de Salud Chachapoyas encargada de gestionar de manera eficaz, eficiente y oportuna los procesos de vigilancia epidemiológica, inteligencia sanitaria, salud global, respuesta y control de brotes, epidemias y otros eventos de importancia en salud pública.

La Oficina de Epidemiología publica semanalmente el Boletín Epidemiológico cuya información es producto de la notificación de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, Gobiernos regionales, EsSalud, Sanidades de fuerzas armadas y policiales, y privados, que conforman la Red de Unidades notificantes e Informantes de la Red de Salud Chachapoyas, además de información o análisis especializado que desarrolla esta Oficina.

Su finalidad es difundir la situación epidemiológica de las provincias de Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza y Bongará, la ocurrencia de brotes y/o epidemias para una adecuada y oportuna toma de decisiones en prevención y control en salud pública.



Lic. Enf. Lith Mariela Malqui Zuta
Responsable de Epidemiología
Red de Salud Chachapoyas

Análisis y Situación de Salud

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES:

Situación Epidemiológica de Varicela:

El virus varicela-zóster (VVZ) produce dos formas clínicas, la varicela y el herpes zóster. La varicela es una enfermedad aguda que cursa con fiebre leve o moderada, síntomas generales, luego aparece un exantema macular auto limitado (a veces con compromiso de mucosas o enantema), que rápidamente evoluciona a pápulas, luego a vesículas y finalmente a costras que se desprenden tras una a dos semanas. Generalmente es benigna en la infancia, pero en adultos puede ocasionar neumonía o encefalitis, dejar secuelas permanentes y causar la muerte.

Se transmite de persona a persona desde dos días antes de la aparición de la erupción hasta que desaparecen las vesículas. También puede ser contraída a partir de las lesiones de una persona con herpes zóster. Quienes contraen la enfermedad a partir de otro familiar, suelen presentar formas más graves que los primeros casos, puede ser por un contacto más intenso y continuado con el virus.

La varicela es muy contagiosa, de manera que el 80–90% de quienes conviven la contraen. En países con clima templado, el 90% de la población padece la varicela antes de los 15 años de edad y el 95% antes de llegar a la vida adulta.

En la Red de Salud Chachapoyas se realiza la vigilancia epidemiológica de este evento mediante la notificación semanal, correspondiente a una vigilancia de tipo pasiva. Hasta la Semana Epidemiológica **(SE 25)** del año 2026, se han reportado un total de 10 casos de varicela sin complicaciones; todos ellos son autóctonos, con una incidencia acumulada (IA) de 5.81 por 100 000 habitantes. ***(Ver Tabla N° 01)***

Los casos autóctonos reportados proceden de las provincias de Rodríguez de Mendoza (06) y Luya (04), evidenciándose que ambas son las más afectadas por esta enfermedad. A nivel distrital, San Nicolás, Limabamba, Cochamal, Colcamar, Lámud y María son los que registran el mayor número de casos de varicela. ***(Ver Tabla N° 02 y N° 03)***

Según la clasificación clínica, el 100% (10/10) de los casos notificados hasta la presente semana epidemiológica corresponden a casos de varicela sin complicaciones. ***(Ver Gráfico N° 01)***

Según el curso de vida, hasta la presente Semana Epidemiológica **(SE 25)**, el grupo etario más afectado corresponde al de niños de 0 a 11 años, que concentra el 70% (07/10) del total de casos notificados. En segundo lugar, se ubica el grupo de adultos de 30 a 59 años, con el 20% (02/10) de los casos; finalmente, el grupo de jóvenes de 18 a 29 años representa el 10% (01/10) del total registrado. ***(Ver Gráfico N° 02)***

Según el gráfico de tendencias, se observa una disminución del 79.59% (39 casos) en comparación con los casos reportados en el mismo periodo del año 2025. ***Ver Gráfico N° 03)***

Según el último decenio se evidencia que en el año 2017 se reportaron la mayor cantidad de casos de varicela, asimismo la incidencia fue la más alta en referencia a los demás años del último decenio. ***(Ver Gráfico N° 04)***

Según el canal endémico por lo notificado en la Semana Epidemiológica **(SE 25)** la ubicación de los casos de varicela es la **Zona de Éxito,** zona que representa el 72% (18/25) del total de semanas epidemiológicas reportadas. ***(Ver Gráfico N° 05)***

Tabla N° 01. Red de Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Varicela y TIA. Años 2021 - 2026*

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos	4	10	16	18	49	10
IA x 100 Mil Hab.	2.32	5.82	9.26	10.48	28.50	5.81
Defunciones	0	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 02. Red Integrada de Salud Chachapoyas, Casos de Varicela, según provincias. Años 2021–2026*

PROVINCIA	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONGARA	1	3	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0
CHACHAPOYAS	4	9	20	18	37	0	1	6	9	2	32	0
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	3	22	16	16	8	4	2	2	5	8	7	4
RODRIGUEZ DE MENDOZA	3	6	9	35	10	6	1	2	2	8	8	6
UTCUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	11	40	45	69	60	10	4	10	16	18	49	10

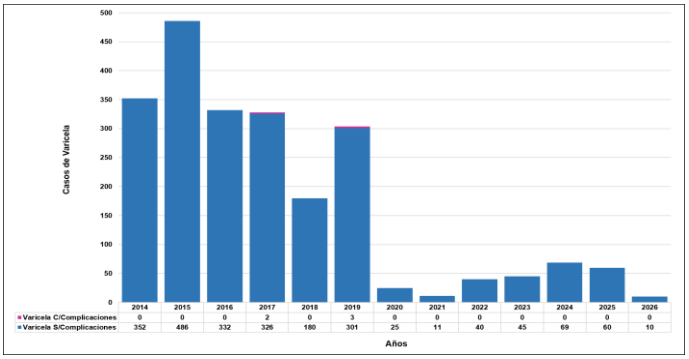
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 03. Red Integrada de Salud Chachapoyas, Casos de Varicela, según distritos. Años 2021–2026*

DISTRITOS	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
CHUQUIBAMBA	1	1	2	13	20	0	0	0	0	0	0	0
SAN NICOLAS	1	5	6	20	2	3	1	2	1	2	2	3
CHACHAPOYAS	0	5	0	2	12	0	0	5	0	1	10	0
OCUMAL	0	1	3	9	5	1	0	0	3	7	4	1
CONILA	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAMUD	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	1
LA JALCA	0	0	10	0	0	0	0	0	8	0	0	0
MARISCAL BENAVIDES	0	0	0	4	4	0	0	0	0	1	4	0
CHILIQUIN	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEIMEBAMBA	2	1	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0
HUAMBO	0	0	1	5	0	0	0	0	0	3	0	0
FLORIDA	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0
LONGAR	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0
LIMABAMBA	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2
COCABAMBA	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PISUQUIA	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
OMIA	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
VISTA ALEGRE	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0
SANTA CATALINA	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0
SANTO TOMAS	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLOCO	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
SAN FRANCISCO DE YESO	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
MONTEVIDEO	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
CAMPORREDONDO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
LONYA CHICO	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JUMBILLA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTA ROSA	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
MARIA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
TINGO	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
COLCAMAR	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
ASUNCION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COCHAMAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
CHIRIMOTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
MOLINOPAMPA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
JAZAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARISCAL CASTILLA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CHISQUILLA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGUILPATA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
BALSAS	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
OCALLI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	11	40	45	69	60	10	4	10	16	18	49	10

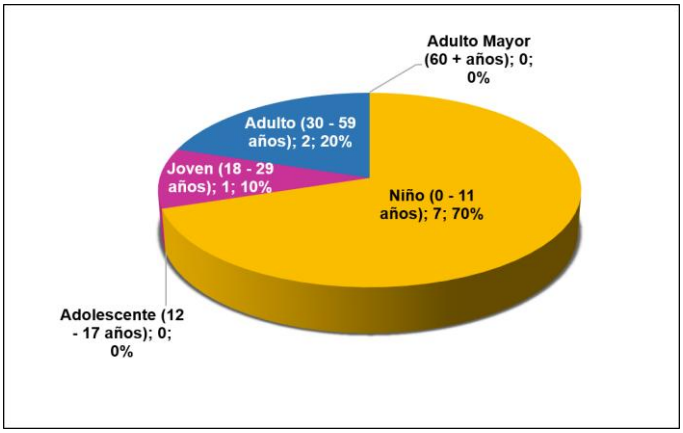
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 01. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Varicela, según tipo de diagnóstico. Años 2014 - 2026*



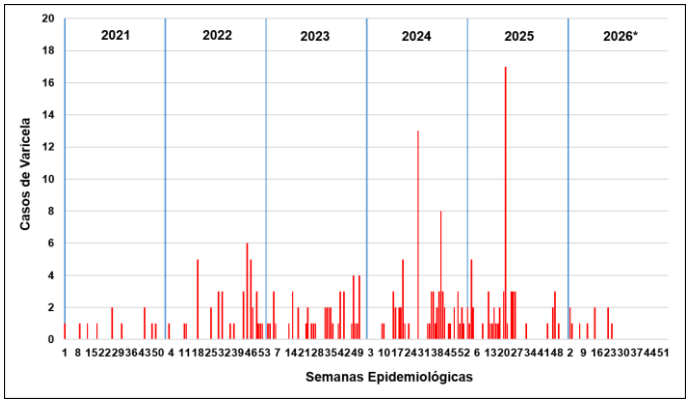
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 02. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos y Porcentaje de Varicela, Según Curso de Vida. Año 2026*



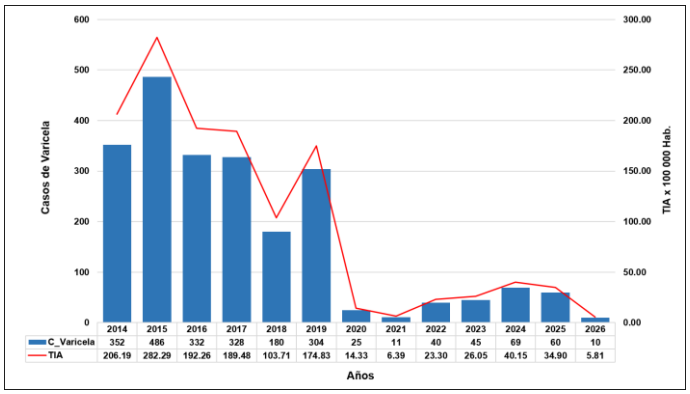
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 03. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de casos de Varicela. Años 2021 - 2026*



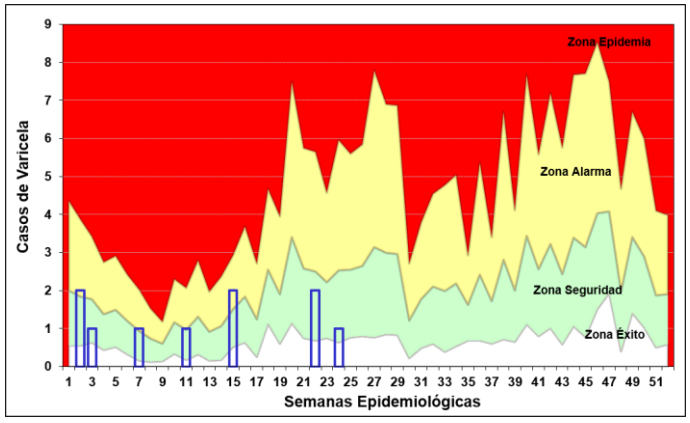
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 04. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Evolución de los casos de Varicela y TIA. Años 2014 - 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 05. Red de Salud Chachapoyas: Canal Endémico de Varicela. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Situación Epidemiológica de Parotiditis Infecciosa:

Es una enfermedad vírica aguda que se caracteriza por fiebre, hinchazón y dolor a la palpación de una o varias glándulas salivales; generalmente la parótida, y a veces las glándulas sublinguales o las submaxilares.

El virus de la parotiditis infecciosa, es miembro de la familia Paramyxoviridae, del género Rubulavirus; se puede transmitir por el aire, o por diseminación de gotitas expulsadas de las vías respiratorias, también por contacto directo con la saliva de una persona infectada. El periodo de incubación es de 16 a 18 días, con límites de 12 a 25 días.

El virus se ha aislado en la saliva (desde siete días antes hasta nueve días después del inicio clínico del cuadro) y la orina (desde seis días antes hasta 15 días después. El período de máxima infecciosidad abarca desde dos días antes del comienzo de la enfermedad, hasta cuatro días después de este. Las infecciones asintomáticas pueden ser transmisibles.

En 20 a 30% de los varones pospúberes afectados se presenta orquitis, que suele ser unilateral, pero es extraordinariamente raro que aparezca esterilidad, en el 31% de las mujeres mayores de 15 años puede aparecer mastitis. No menos de 40 a 50% de los casos de parotiditis se han asociado a síntomas de las vías respiratorias, particularmente en los niños menores de 5 años.

La parotiditis puede causar pérdida auditiva neurosensorial, tanto en los niños como en los adultos. En 4% de los casos aparece pancreatitis, por lo regular leve, pero no se ha demostrado que guarde la relación sugerida con la diabetes. La enfermedad es benigna y autolimitada y un tercio de las personas tienen infección subclínica. Al igual que sucede en otras infecciones virales, la enfermedad es más grave en las personas mayores.

La parotiditis durante el primer trimestre del embarazo puede aumentar la incidencia de aborto espontáneo, pero no hay pruebas definitivas de que la enfermedad durante la gestación produzca malformaciones congénitas.

El diagnóstico definitivo de parotiditis epidémica se basa en el aislamiento viral en saliva, desde 7 días antes hasta 9 días después del agrandamiento de las glándulas salivares, y en orina desde 6 días antes a 15 días después del inicio de la parotiditis.

En la Red de Salud Chachapoyas, la Vigilancia Epidemiológica de la Parotiditis se realiza mediante la Notificación Semanal, correspondiente a una vigilancia de tipo pasiva. Hasta la presente Semana Epidemiológica **(SE 25)** del año 2026, se ha reportado un total de 01 caso de parotiditis, el cual fue clasificado como autóctono, registrándose una incidencia acumulada (IA) de 0.58 por 100 000 habitantes. ***(Ver Tabla N° 04)***

El caso notificado procede de la provincia de Rodríguez de Mendoza del distrito de San Nicolás. ***(Ver Tabla N° 05 y N° 06)***

Según la clasificación clínica, el 100% (01/01) de los casos notificados hasta la presente Semana Epidemiológica **(SE 25)** corresponden a casos de parotiditis sin complicaciones. ***(Ver Gráfico N° 06)***

Según curso de vida, el grupo etario más afectado en la presente Semana Epidemiológica **(SE 25)** corresponde a los adolescentes de 12 a 17 años, representando el 100% (01/01) de los casos reportados. ***(Ver Gráfico N° 07)***

Según sexo, el 100% (01/01) de los casos notificados corresponden al sexo masculino, no registrándose casos en el sexo femenino. ***(Ver Gráfico N° 08)***

Según el gráfico de tendencias, se aprecia un aumento del 100% (01 caso) en relación con los casos reportados en el mismo periodo del año 2025. ***(Ver Gráfico N° 09)***

Según el último decenio se evidencia que en el año 2018 se reportaron la mayor cantidad de casos de parotiditis, asimismo la incidencia fue la más alta en referencia a los demás años del último decenio. En el año 2018 a partir de la SE 36 se notificaron un incremento de casos de parotiditis entre casos aislados y conglomerados. Desde el nivel nacional y regional se realizaron la elaboración y difusión de las alertas epidemiológicas, por lo que los Establecimientos de Salud continúan con el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. ***(Ver Gráfico N° 10)***

Tabla N° 04. Red de Salud Chachapoyas: Casos de Parotiditis y TIA. Años 2021 - 2026*

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos	3	4	3	4	0	1
IA x 100 Mil Hab.	1.74	2.33	1.74	2.33	0.00	0.58
Defunciones	0	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 05. Red Integrada de Salud Chachapoyas, Casos de Parotiditis, según provincias. Años 2021–2026*

PROVINCIA	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONGARA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHACHAPOYAS	2	2	2	1	3	0	1	1	0	0	0	0
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	3	2	7	7	1	0	2	1	3	4	0	0
RODRIGUEZ DE MENDOZA	0	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1
UTCUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	5	6	10	9	4	1	3	4	3	4	0	1

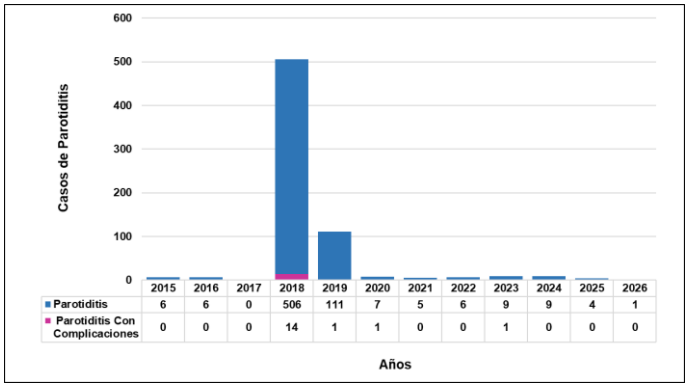
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 06. Red Integrada de Salud Chachapoyas, Casos de Varicela, según distritos. Años 2021–2026*

DISTRITO	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
OCUMAL	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0
CHACHAPOYAS	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
PROVIDENCIA	1	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
LAMUD	1	0	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0
SAN NICOLAS	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
LEIMEBAMBA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMPORREDONDO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
LA JALCA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTA CATALINA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
CHUQUIBAMBA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BALSAS	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JUMBILLA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCALLI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LONGUITA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTO TOMAS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTORA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MARIA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
LONGAR	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Total general	5	6	10	9	4	1	3	4	3	4	0	1

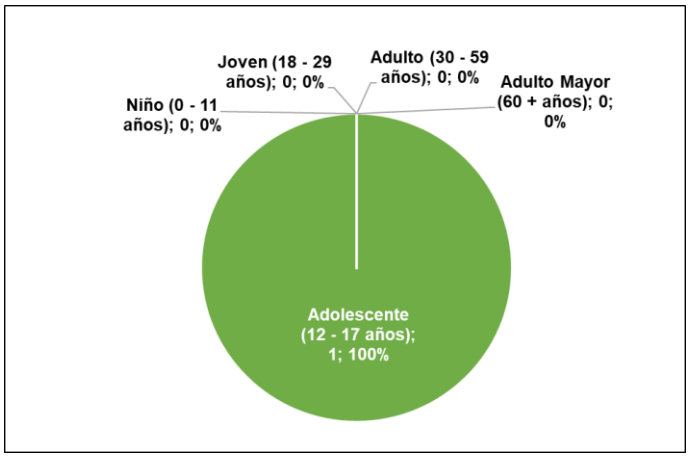
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 06. Red de Salud Chachapoyas: Casos de Parotiditis, según tipo de Diagnóstico. Años 2015 - 2026*



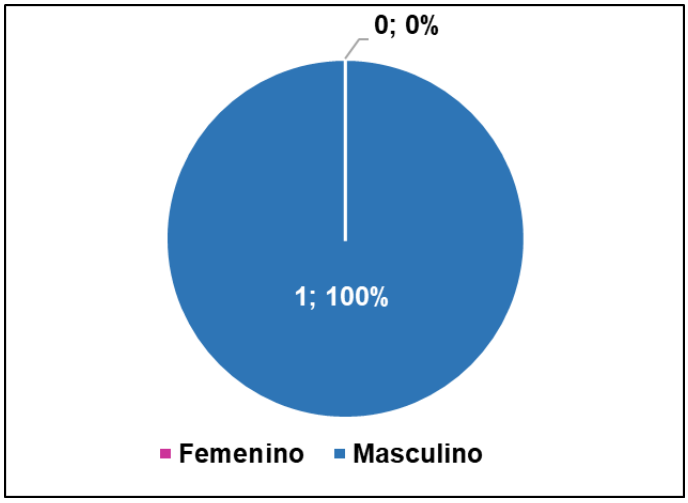
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 07. Red de Salud Chachapoyas: Casos y Porcentaje de Parotiditis, según Curso de Vida. Año 2026*



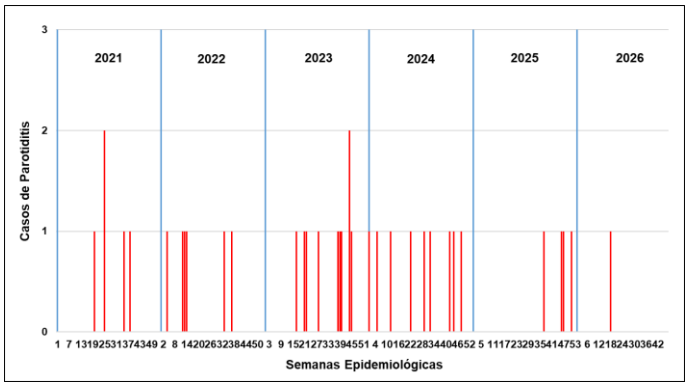
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 08. Red de Salud Chachapoyas: Casos de Parotiditis, según Sexo. Año 2024*



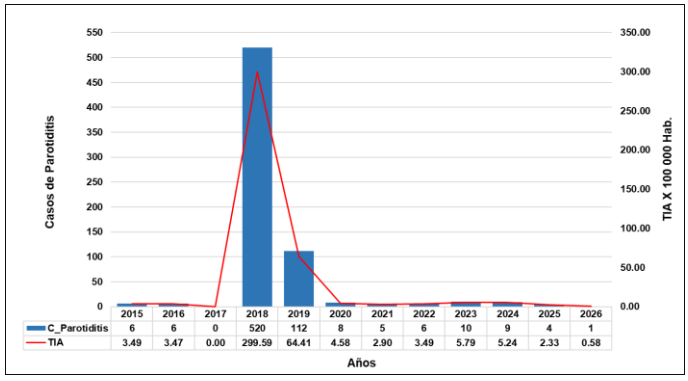
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 09. Red de Salud Chachapoyas: Tendencia de casos de Parotiditis. Años 2021 - 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 10. Red de Salud Chachapoyas: Evolución de los casos de Parotiditis y TIA. Años 2015 - 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

ENFERMEDADES METAXENICAS:

Situación Epidemiológica de Leishmaniosis:

La **leishmaniosis cutánea** es una enfermedad causada por parásitos, transmitidos al ser humano por la picadura de distintas especies de insectos flebótomos.

La **leishmaniosis cutánea** es una enfermedad de evolución crónica que se adquiere en las zonas rurales. El cuadro clínico varía de acuerdo al tipo de parásito, al medio ambiente y a la respuesta inmune del huésped. El periodo de incubación es variado, va desde las dos semanas hasta varios meses.

Su epidemiología depende de las características de la especie del parásito, las características ecológicas locales de los lugares donde se transmite, la exposición previa y actual de la población humana al parásito y las pautas de comportamiento humano.

Se conocen más de 90 especies de flebotominos transmisores de Leishmania. El principal vector en la Región Amazonas y en la jurisdicción de la Red de Salud Chachapoyas, es la Lutzomya.

La enfermedad se presenta en tres formas principales:

Leishmaniosis visceral, en más del 95% de los casos es mortal si no se trata. Se caracteriza por episodios irregulares de fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y anemia. En la Región Amazonas no se han reportado casos de este tipo de leishmaniasis.

Leishmaniosis cutánea, es la forma más frecuente de leishmaniasis, y produce en las zonas expuestas del cuerpo lesiones cutáneas, sobre todo ulcerosas, que dejan cicatrices de por vida y son causa de discapacidad grave.

Leishmaniosis mucocutánea, conduce a la destrucción parcial o completa de las membranas mucosas de la nariz, la boca y la garganta.

En la Red de Salud Chachapoyas, hasta la Semana Epidemiológica **(SE 25),** las unidades notificantes han reportado un total de 43 casos de leishmaniosis (C=43), todos ellos autóctonos, con una incidencia acumulada (IA) de 24.99 por 100 000 habitantes. ***(Ver Tabla N° 07)***

La provincia que reporta el mayor número de casos de leishmaniasis es Chachapoyas, con el 46.51% (20/43). Asimismo, los 39 casos autóctonos proceden de las provincias de Chachapoyas (20), Luya (10), Bongará (08) y Rodríguez de Mendoza (05). A nivel distrital, el distrito más afectado es La Jalca, con 12 casos. ***(Ver Tabla N° 08 y N° 09)***

Según el gráfico de tendencias, se aprecia una disminución del 67.42% (89 casos) en comparación con los casos reportados para el mismo periodo del año 2025. Asimismo, en el último quinquenio se evidencia que la tendencia ha sido oscilante a lo largo de los años, siendo el año 2025 el de menor notificación, con un total de 157 casos. ***(Ver Gráfico N° 11)*** Según el último decenio, se evidencia que en el año 2018 (339 casos) se reportó la mayor cantidad de casos de leishmaniasis; asimismo, la incidencia fue la más alta en comparación con los demás años del mismo periodo. ***(Ver Gráfico N° 12)***

Según la clasificación clínica, se evidencia que el 100% (43/43) de los casos notificados corresponden a leishmaniosis cutánea y el 0% (00/43) a leishmaniosis mucocutánea. ***(Ver Gráfico N° 13)***

Según el curso de vida, el grupo etario más afectado durante la presente Semana Epidemiológica **(SE 25)** corresponde a los adultos de 30 a 59 años, quienes concentran el 44% (19/43) del total de casos. Le siguen los adultos mayores de 60 años a más con el 21% (09/43), los niños de 0 a 11 años con el 16% (07/43), los adolescentes de 12 a 17 años con el 12% (05/43) y, finalmente, los jóvenes de 18 a 29 años con el 7% (03/43) de los casos notificados. ***(Ver Gráfico N° 14)***

El 53% de los casos notificados corresponde al sexo masculino (23/43) y el 47% restante al sexo femenino (20/43). ***(Ver Gráfico N° 15)***

Según el canal endémico, se evidencia que para la presente Semana Epidemiológica **(SE 25),** la ubicación de los casos notificados de leishmaniosis corresponde a la **Zona de Éxito,** debido a que los casos fueron asignados a semanas anteriores según la fecha de inicio de síntomas. ***(Ver Gráfico N° 16)***

Tabla N° 07. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leishmaniasis y TIA. Años 2021 - 2026*

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos	98	119	119	106	132	43
IA x 100 Mil Hab.	56.90	69.30	68.90	61.71	76.78	24.99
Defunciones	0	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 08. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leishmaniasis, según Provincias. Año 2026*

PROVINCIA	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
BONGARA	41	40	37	31	20	8	25	25	22	15	14	8
CHACHAPOYAS	56	60	97	73	48	20	32	41	48	41	39	20
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	69	81	77	50	56	10	33	44	36	31	47	10
RODRIGUEZ DE MENDOZA	15	20	33	33	33	5	8	9	13	19	32	5
UTCUBAMBA	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0
Total general	182	203	245	189	157	43	98	120	119	107	132	43

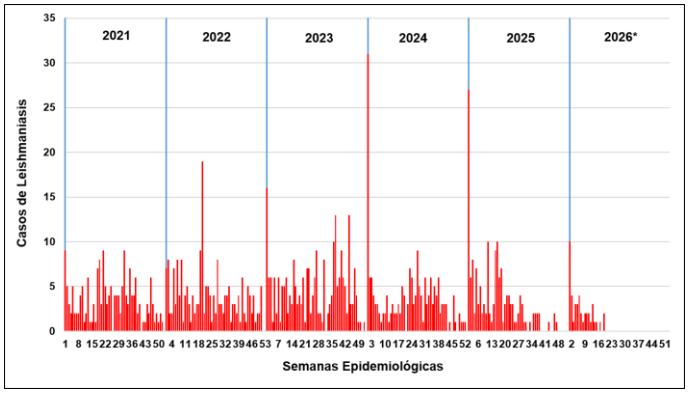
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 09. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leishmaniasis, según Distritos. Año 2026*

DISTRITOS	Casos Acumulados						Corte SE. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
LA JALCA	21	17	29	35	12	12	10	14	19	24	12	12
TINGO	30	28	34	15	9	1	15	15	11	11	7	1
CHACHAPOYAS	11	28	27	13	16	2	8	20	10	4	13	2
JAZAN	27	21	22	14	10	2	17	14	11	7	7	2
OMIA	7	4	18	24	25	2	4	4	5	14	24	2
MAGDALENA	14	8	22	16	12	2	7	2	9	9	8	2
COCABAMBA	9	20	9	8	10	1	4	9	6	6	8	1
COLCAMAR	7	11	8	7	13	3	3	3	3	3	11	3
SANTO TOMAS	9	10	7	5	4	3	4	8	4	4	4	3
VALERA	6	12	9	5	1	2	3	6	8	4	1	2
CHURUJA	5	2	5	7	3	1	3	1	3	3	2	1
MARISCAL CASTILLA	6	1	3	5	1	3	4	1	1	1	1	3
SAN NICOLAS	0	6	4	3	4	1	0	1	2	0	4	1
LIMABAMBA	3	4	5	1	0	1	2	1	2	1	0	1
PISUQUIA	5	5	2	1	1	0	3	4	2	1	1	0
LEIMEBAMBA	2	3	5	0	1	1	2	3	5	0	1	1
SAN FRANCISCO DE YESO	2	3	1	3	3	0	2	3	0	0	3	0
MILPUCC	4	4	2	1	1	0	1	3	2	1	1	0
CHILIQUIN	1	0	4	3	3	0	1	0	0	2	2	0
INGUILPATA	1	1	3	2	2	0	0	1	1	0	1	0
CHIRIMOTO	0	0	3	3	3	0	0	0	1	2	3	0
SHIPASBAMBA	2	3	0	0	1	2	2	2	0	0	1	2
LONYA CHICO	0	0	2	3	3	0	0	0	2	1	1	0
YAMBRASBAMBA	1	1	0	2	2	1	0	1	0	0	2	1
LAMUD	0	1	3	2	0	1	0	0	2	2	0	1
FLORIDA	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0
LUYA	0	1	2	0	3	0	0	0	1	0	3	0
MONTEVIDEO	1	2	2	0	1	0	0	1	2	0	1	0
SAN JUAN DE LOPECANCHA	2	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0
OCALLI	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
MARIA	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
SAN ISIDRO DE MAINO	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0
HUAMBO	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0
PROVIDENCIA	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
CONILA	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0
SANTA CATALINA	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0
CUISPES	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
LONYA GRANDE	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
BAGUA GRANDE	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SAN CRISTOBAL	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
SONCHE	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
CUMBA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HUANCAS	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
OCUMAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
BALSAS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEVANTO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TOTORA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
LONGAR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COCHAMAL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOLINOPAMPA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAGUA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
CAMPORREDONDO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Total general	182	203	245	189	157	43	98	120	119	107	132	43

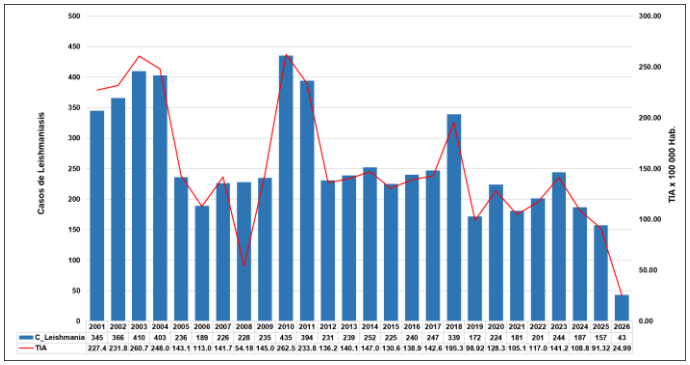
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 11. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de casos de Leishmaniasis. Años 2021 - 2026*



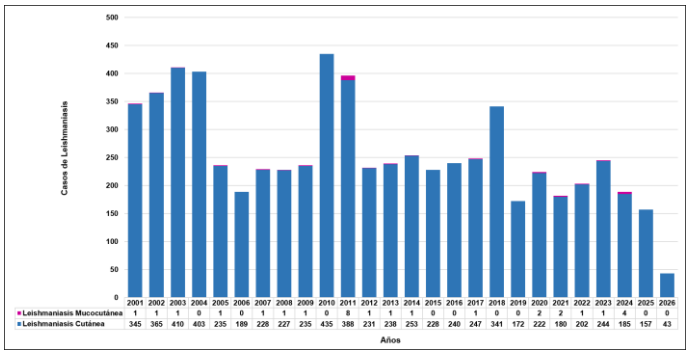
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 12. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Evolución de los casos de Leishmaniasis y TIA. Años 2001 - 2026*



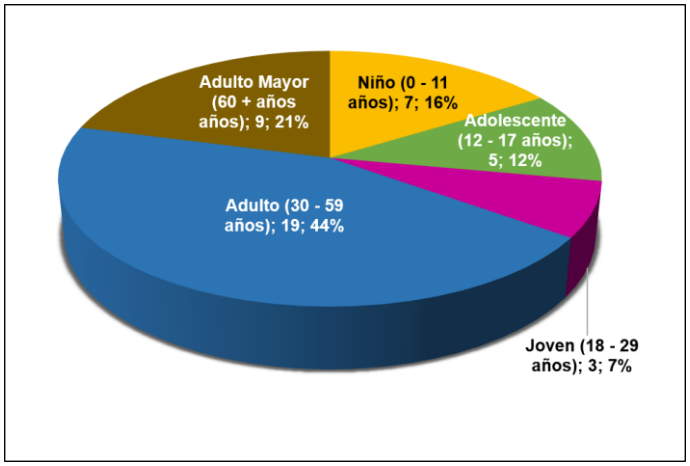
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 13. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leishmaniosis, según Tipo de Diagnóstico. Años 2001 - 2026*



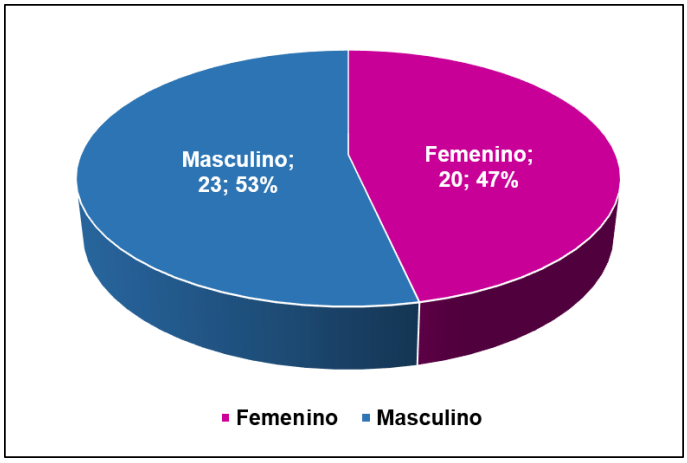
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 14. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos y Porcentaje de Leishmaniosis, Según Curso de Vida. Año 2026*



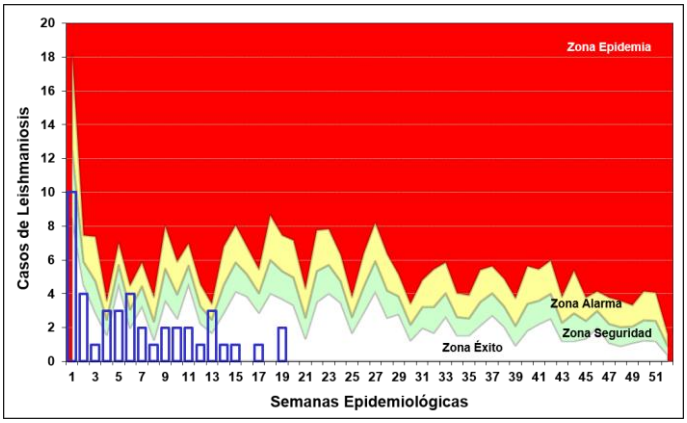
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 15. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leishmaniosis, Según Sexo. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 16. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Canal Endémico de Leishmaniosis. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Situación Epidemiológica de Dengue:

El dengue en Perú constituye un reto creciente para la salud pública, con episodios frecuentes de brotes que se ven intensificados por factores ambientales y la alta densidad poblacional en zonas urbanas, que promueven la expansión del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de esta enfermedad viral. En particular, el aumento de las temperaturas y los patrones de lluvia han agravado este problema. En muchas áreas afectadas la comunidad no se involucra adecuadamente en las iniciativas de control de la enfermedad. Por ello, es crucial dar prioridad al primer nivel de atención, donde se concentra la mayoría de los casos.

El dengue es una enfermedad febril aguda producida por el virus denominado con el mismo nombre. El virus dengue (VD) tiene cuatro serotipos. (DEN – 1, DEN – 2, DEN – 3 y DEN – 4), es transmitido al humano por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado.

En la Red de Salud Chachapoyas, hasta la Semana Epidemiológica **(SE 25)**, se ha notificado al sistema de vigilancia un total de **13 casos** de dengue **(C=13)**, siendo **04 casos autóctonos** con una **IA 2.32 x 100 000 habitantes.** ***(Ver Tabla N° 10)***

Las provincias que reportan el mayor número de casos de dengue autóctonos son Bongará y Luya, cada una con el 15.38 % (02/13) del total de casos notificados. A nivel distrital, los distritos más afectados son Jazán y San Jerónimo, con dos (02) casos registrados en cada uno. Por otro lado, los casos importados proceden de diferentes jurisdicciones de la región. En la provincia de Utcubamba, distrito de Bagua Grande, se registraron seis (06) casos, y en el distrito de Jamalca un (01) caso, en la provincia de Bagua, distrito de Bagua, se registró un (01) caso y en la provincia de Condorcanqui, distrito de Nieva, un (01) caso. ***(Ver Tabla N° 11 y N° 12)***

De acuerdo con la clasificación clínica, el 77% (10/12) de los casos corresponde a dengue sin signos de alarma, mientras que el 23% (03/13) corresponde a dengue con signos de alarma. ***(Ver Gráfico N° 17)***

El 54% de los casos notificados corresponde al sexo femenino (07/13) y el 46% restante al sexo masculino (06/13). ***(Ver Gráfico N° 18)***

Según curso de vida, el grupo de edad más afectado para esta Semana Epidemiológica **(SE 25)** son los adultos de 30 – 59 Años con el 61% (08/13). Asimismo, los jóvenes de 18 – 29 años concentran el 23% (03/13), los niños de 0 – 11 años y adultos mayores de 60 años a más el 8% (01/13) del total de casos cada uno, rspectivamente. ***(Ver Gráfico N° 19)***

Según el gráfico de tendencias, se aprecia una disminución de 50% (04 casos) en relación a los casos reportados para el mismo periodo del año 2025. ***(Ver Gráfico N° 20)***

Según el último quinquenio se evidencia que en el año 2023 se reportó la mayor cantidad de casos de dengue, asimismo la incidencia fue la más alta en referencia a los demás años del último quinquenio. ***(Ver Gráfico N° 21)***

Tabla N° 07. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Dengue y TIA. Años 2021 - 2026*

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos	0	29	44	45	8	4
IA x 100 Mil Hab.	0.00	16.89	25.47	26.20	4.65	2.32
Defunciones	0	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 08. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Dengue, Según Provincias. Años 2021 - 2026*

PROVINCIA	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	6	4	10	6	1	0	4	3	7	6	1
BONGARA	1	0	90	59	8	2	0	0	33	45	8	2
CHACHAPOYAS	26	29	13	0	0	0	0	29	11	0	0	0
CONDORCANQUI	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
LUYA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
RODRIGUEZ DE MENDOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTCUBAMBA	5	7	11	14	5	7	0	4	5	9	4	7
Total general	33	43	118	84	20	13	1	38	52	61	19	13

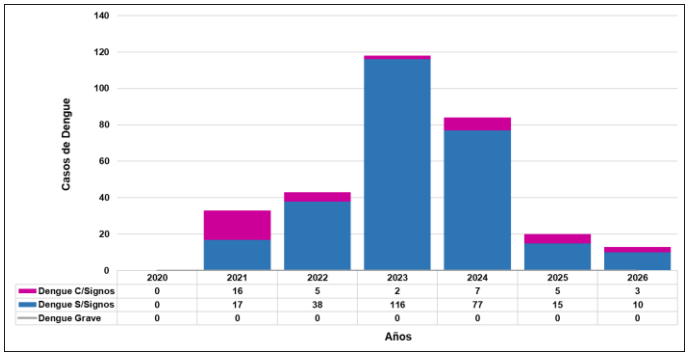
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 09. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Dengue, Según Distritos. Años 2021 - 2026*

DISTRITOS	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
JAZAN	1	0	90	59	8	2	0	0	33	45	8	2
BALSAS	26	29	13	0	0	0	0	29	11	0	0	0
BAGUA GRANDE	0	7	9	6	4	6	0	4	5	5	3	6
BAGUA	0	4	3	6	6	1	0	2	2	4	6	1
JAMALCA	5	0	2	6	1	1	0	0	0	2	1	1
NIEVA	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
IMAZA	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0
SAN JERONIMO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
CAJARURO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
COPALLIN	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
ARAMANGO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
EL PARCO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Total general	33	43	118	84	20	13	1	38	52	61	19	13

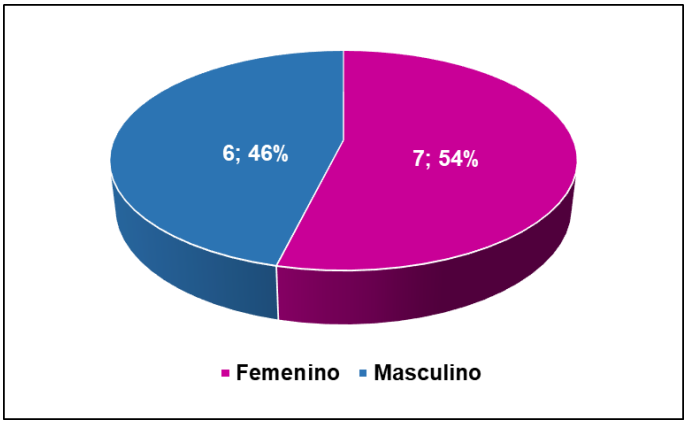
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 17. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Dengue, Según Clasificación Clínica. Años 2020 - 2026*



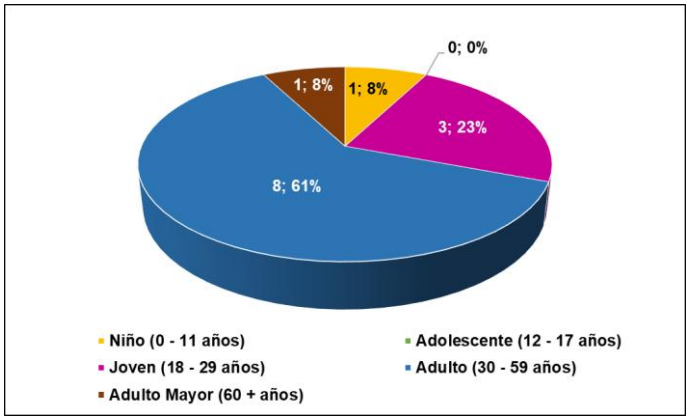
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 18. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Dengue, Según Sexo. Año 2026*



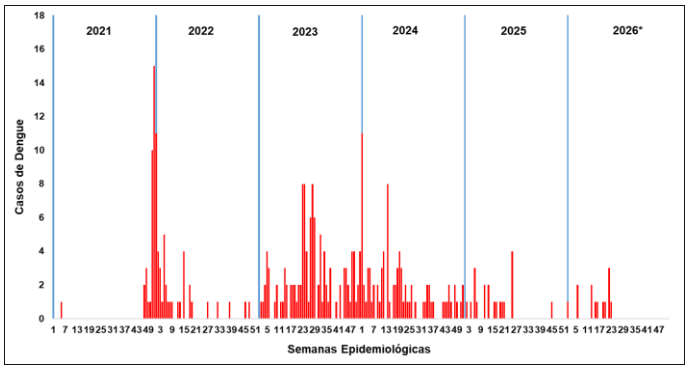
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 19. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos y Porcentaje de Dengue, Según Curso de Vida. Año 2026*



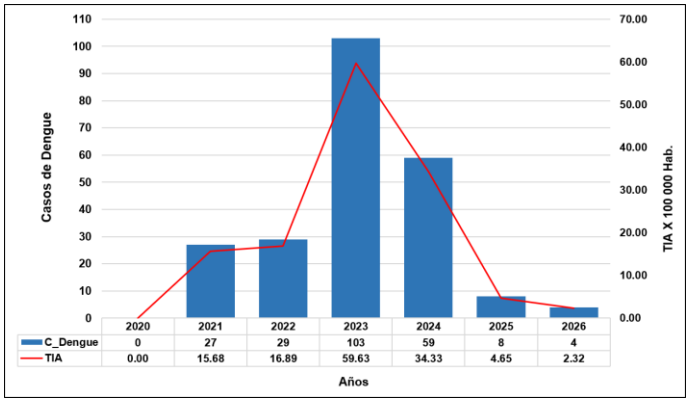
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 20. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de Casos de Dengue. Años 2021 – 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 21. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Evolución de los casos de Dengue y TIA. Años 2020 – 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

ENFERMEDADES ZOONÓTICAS:

Situación Epidemiológica de Leptospirosis:

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, causada por una bacteria llamada leptospira.

La leptospirosis puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal. Sus síntomas pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral; es importante el diagnóstico correcto (clínico y de laboratorio) al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas principalmente en situaciones de brotes.

Algunos de los factores de riesgo incluyen:

- Exposición ocupacional: agricultores, granjeros, trabajadores de los mataderos, cazadores (tramperos), veterinarios, leñadores, personas que trabajan en el alcantarillado, personas que trabajan en arrozales y personal militar.
- Actividades recreativas: nadar en aguas dulces, hacer canotaje, hacer kayak y ciclomontañismo en áreas cálidas.
- Exposición en el hogar: tener perros como mascotas, ganado doméstico, sistemas de recolección de agua de lluvia y roedores infectados.

Síntomas:

Los síntomas pueden tardar de 2 a 30 días (un promedio de 10 días) en aparecer y pueden incluir: Tos seca, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, vómitos y diarrea y escalofríos.

Los síntomas menos comunes incluyen: Dolor abdominal, ruidos pulmonares anormales, dolor de hueso, enrojecimiento sin fluido de la conjuntiva (superficie de la parte blanca de los ojos), inflamación de los ganglios linfáticos, agrandamiento del bazo o el hígado, dolores articulares, rigidez muscular, sensibilidad muscular, erupción cutánea y dolor de garganta.

Pruebas y exámenes:

Se analiza la sangre en busca anticuerpos contra la bacteria. Durante algunas fases de la enfermedad, las bacterias en sí pueden ser detectadas con un examen de reacción en cadena de polimerasa (RCP).

Otros exámenes que se pueden hacer son: Conteo sanguíneo completo (CSC), creatina cinasa, enzimas hepáticas, análisis de orina y hemocultivo.

Prevención:

Evite áreas de aguas estancadas o de inundaciones, especialmente en los climas tropicales. Si usted está expuesto a un área de alto riego, tome precauciones para evitar la infección. Utilice ropa, zapatos o botas de protección cuando se acerque a agua o suelo contaminado con orina animal. Puede tomar doxiciclina para disminuir el riesgo.

En la Red de Salud Chachapoyas, hasta la Semana Epidemiológica **(SE 25)**, se ha notificado al sistema de vigilancia un total de **07 casos** de Leptospirosis (C=07), siendo 06 casos **autóctonos** con una **IA 3.49 x 100 000 habitantes.** ***(Ver Tabla N° 13)***

Las provincias que reportan casos autóctonos de leptospirosis son Bongará, con cuatro (04) casos y Rodríguez de Mendoza, con dos (02) casos. A nivel distrital, los distritos más afectados por esta enfermedad son Jazán y Omia. Con respecto al caso importado, se trata de un adulto mayor de sexo masculino, procedente de la provincia de Utcubamba, distrito de Bagua Grande. ***(Ver Tabla N° 14 y N° 15)***

El 57% de casos notificados son de sexo femenino (04/07) y el 43% restante son de sexo masculino (02/07). ***(Ver Gráfico N° 22)***

Según curso de vida, el grupo de edad más afectado para esta Semana Epidemiológica **(SE 25)** son los adultos mayores de 60 años a más con un 43% (03/07); asimismo los adultos de 30 – 59 Años concentran el 29% (02/07), los niños de 0 – 11 años y jóvenes representan el 14% (01/07) cada uno, respectivamente. ***(Ver Gráfico N° 23)***

Según el gráfico de tendencias, se aprecia una disminución de 72.73% (16 casos) en relación a los casos reportados para el mismo periodo del año 2025. ***(Ver Gráfico N° 24)***

Según el último quinquenio se evidencia que en el año 2025 se reportó la mayor cantidad de casos de Leptospirosis, asimismo la incidencia fue la más alta en referencia a los demás años del último quinquenio. ***(Ver Gráfico N° 25)***

Tabla N° 10. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leptospirosis y TIA. Años 2021 - 2026*

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos	0	0	0	2	22	6
IA x 100 Mil Hab.	0.00	0.00	0.00	1.16	12.80	3.49
Defunciones	0	0	0	0	0	1
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 11. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leptospirosis, Según Provincias. Años 2021 - 2026*

PROVINCIA	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BONGARA	0	0	0	10	21	4	0	0	0	0	19	4
CHACHAPOYAS	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
RODRIGUEZ DE MENDOZA	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	2
UTCUBAMBA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Total general	0	0	0	18	24	7	0	0	0	2	22	7

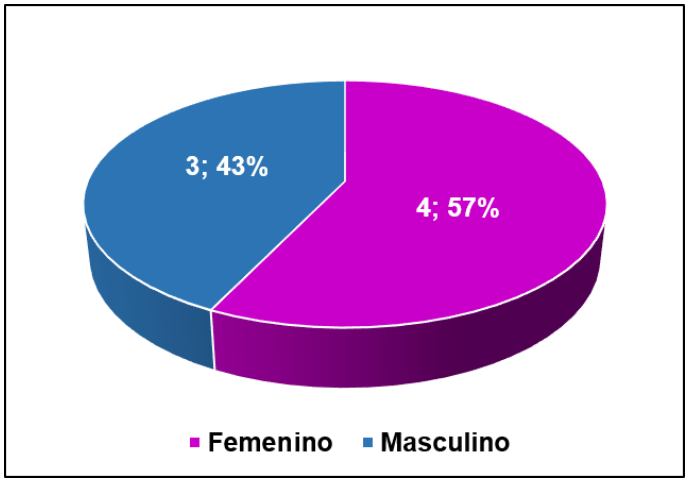
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 12. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leptospirosis, Según Distritos. Años 2021 - 2026*

DISTRITOS	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
JAZAN	0	0	0	8	21	4	0	0	0	0	19	4
CHACHAPOYAS	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
OMIA	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	2
MARISCAL BENAVIDES	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
SAN NICOLAS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
FLORIDA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CONILA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SHIPASBAMBA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
LA JALCA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
LONGAR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
BAGUA GRANDE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
IMAZA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PISUQUIA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	0	0	0	18	24	7	0	0	0	2	22	7

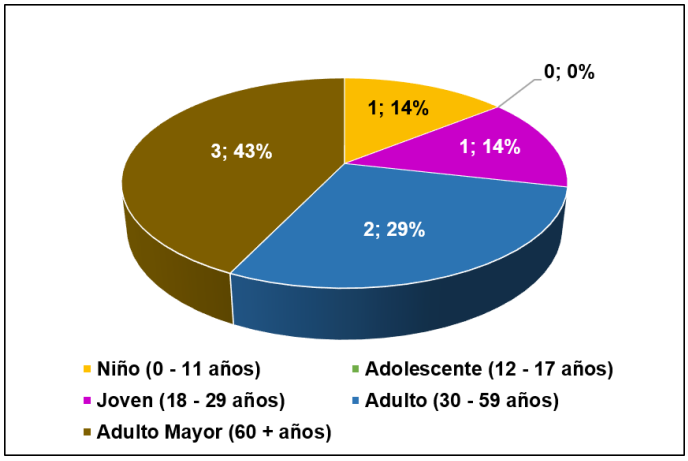
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 22. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Leptospirosis, Según Sexo. Año 2026*



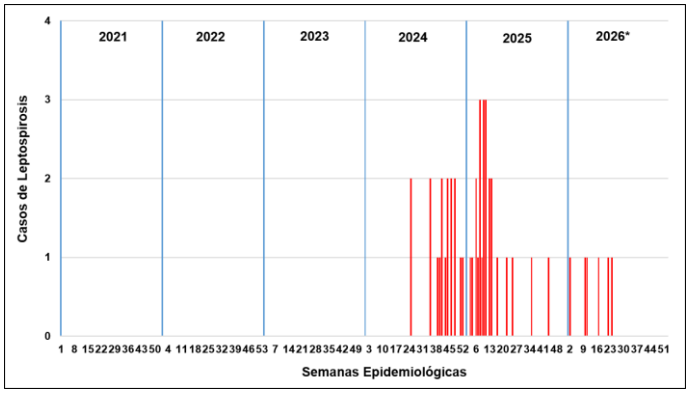
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 23. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos y Porcentaje de Leptospirosis, Según Curso de Vida. Año 2026*



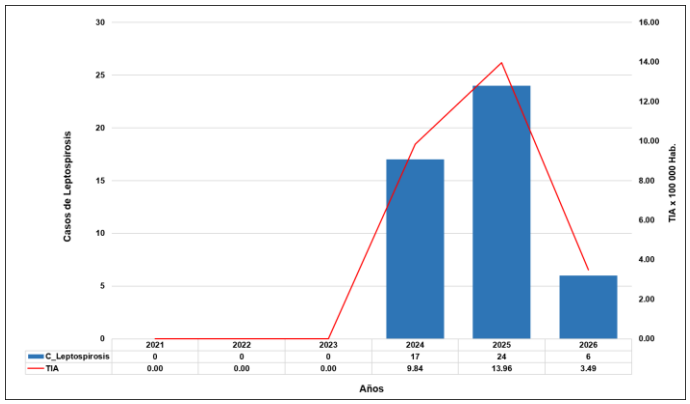
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 24. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de Casos de Leptospirosis. Años 2021 – 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 25. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Evolución de los casos de Leptospirosis y TIA. Años 2020 – 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Situación Epidemiológica de Loxoscelismo:

La vigilancia de los daños de transmisión zoonótica en el Perú fue implementándose progresivamente a través de los años, es así que el loxocelismo se vigila sistemáticamente desde el año 2000; sin embargo, se requiere estandarizar los procedimientos para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades zoonóticas y accidentes por animales ponzoñosos, así como para la vigilancia, comunicación y notificación de epizootias.

Los accidentes por animales ponzoñosos son producidos por la exposición (mordedura, picadura, contacto) a serpientes, arácnidos y otros que al inocular sus toxinas en el organismo provocan una serie de alteraciones fisiopatológicas que dan lugar a signos y síntomas, íntimamente relacionados con el género del animal agresor.

Loxoscelismo, cuadro tóxico producido por el veneno que inyectan arañas del género Loxosceles en el momento de la mordedura, ha sido registrado en la mayoría de los países americanos. Dicho cuadro tóxico puede presentarse bajo dos formas bien definidas: Loxocelismo cutáneo (LC) y Loxocelismo cutáneo-visceral (LCV) o sistémico.

Loxoscelismo, constituye una amenaza importante para la población principalmente en zonas urbanas por la distribución de este insecto y la afección clínica que produce.

En la Red de Salud Chachapoyas, el loxoscelismo muestra un comportamiento estacionario, hasta la presente Semana Epidemiológica **(SE 25),** se ha notificado un total de **07 casos de mordedura por araña,** con una **IA 4.07 x 100 000 habitantes,** procedentes de la provincia de Luya y Rodríguez de Mendoza, de los distritos de Pisuquia (01 caso), Totora (03 casos), Chirimoto (02 casos) y Omia (01 caso). ***(Ver Tabla N° 16, N° 17 y N° 18)***

Según el curso de vida, el grupo de edad más afectado en la presente Semana Epidemiológica **(SE 25)** corresponde a los adultos de 30 a 59 años, quienes concentran el 57% (04/07) de los casos notificados. Le siguen los adultos mayores de 60 años a más, con el 29% (02/07) de los casos, y los adolescentes de 12 a 17 años, con el 14% (01/07). No se registraron casos en los demás grupos etarios. ***(Ver Gráfico N° 26)***

Según el sexo, el 71% (05/07) de los casos de loxoscelismo corresponde al sexo masculino, mientras que el 29% (02/07) se registró en el sexo femenino. ***(Ver Gráfico N° 27)***

Según el gráfico de tendencias, se observa un aumento del 71.43% (05 casos) en comparación con los casos reportados en el mismo periodo del año 2025. ***(Ver Gráfico N° 28)***

En el periodo 2014 - 2026 los casos de Loxoscelismo muestran un comportamiento oscilante, donde el mayor número de casos notificados fue en el año 2019 con la notificación de 86 casos, asimismo la incidencia fue la más alta en referencia a los demás años de este periodo. ***(Ver Gráfico N° 29)***

Tabla N° 16. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Loxocelismo y TIA. Años 2021- 2026*

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos	18	16	29	24	2	7
IA x 100 Mil Hab.	10.45	9.32	16.79	13.96	1.16	4.07
Defunciones	0	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 17. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Loxocelismo, Según Provincias. Años 2021 - 2026*

PROVINCIA	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONGARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHACHAPOYAS	0	0	3	1	0	0	0	0	2	1	0	0
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
RODRIGUEZ DE MENDOZA	45	23	36	30	4	6	18	16	27	23	2	6
UTCUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	45	23	39	31	4	7	18	16	29	24	2	7

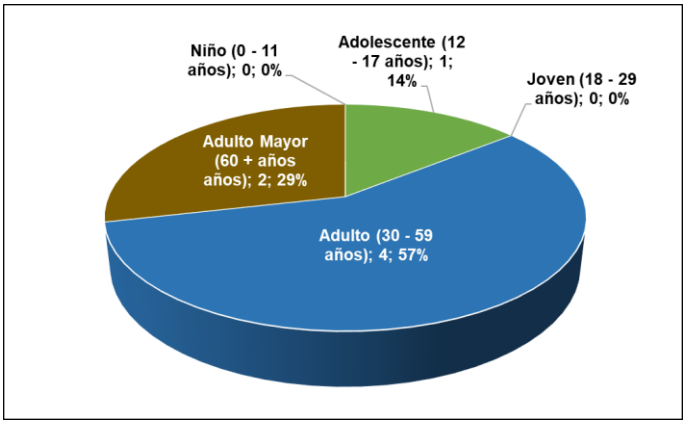
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 18. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Loxocelismo, Según Distritos. Años 2021 - 2026*

DISTRITO	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
OMIA	30	13	24	19	1	1	12	9	20	18	1	1
SAN NICOLAS	5	3	5	6	1	0	3	2	3	2	1	0
MILPUCC	1	2	4	0	0	0	1	1	2	0	0	0
CHIRIMOTO	3	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
LONGAR	3	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
HUAMBO	1	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0
TOTORA	0	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	3
MARISCAL BENAVIDES	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
CHACHAPOYAS	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0
SANTA ROSA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
MOLINOPAMPA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
LIMABAMBA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
PISUQUIA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Total general	45	23	39	31	4	7	18	16	29	24	2	7

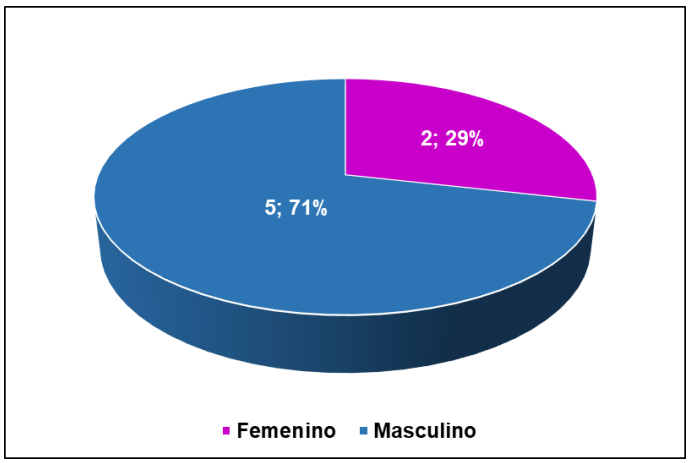
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 26. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos y Porcentaje de Loxoscelismo, Según Curso de Vida. Año 2026*



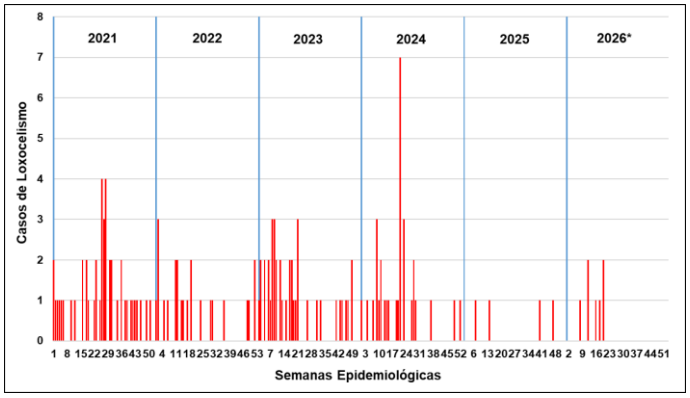
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 27. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Loxoscelismo, Según Sexo. Año 2026*



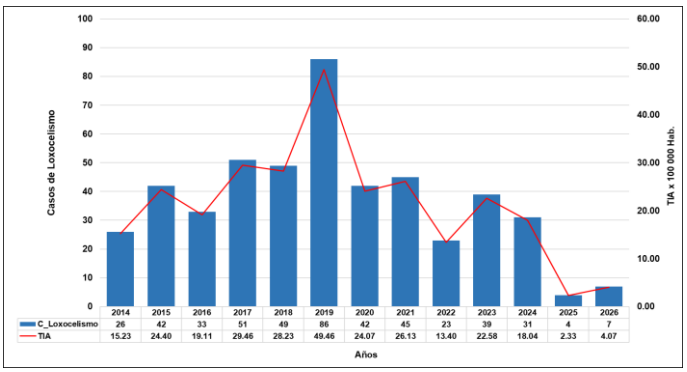
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 28. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de Casos de Loxoscelismo. Años 2021 – 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 29. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Evolución de los casos de Loxoscelismo y TIA. Años 2014 – 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Situación Epidemiológica de Ofidismo:

Las enfermedades zoonóticas constituyen un grave problema de salud pública. Se estima que aproximadamente 61% de los microorganismos patógenos para el hombre y un 75% de los patógenos emergentes son de origen zoonótico.

En este contexto los sistemas de vigilancia en el mundo orientan sus esfuerzos al monitoreo de las tendencias y distribución de estas enfermedades en la población humana, así como en los animales reservorios y susceptibles.

Las poblaciones de mayor riesgo para daños zoonóticos, son principalmente aquellas que presentan niveles socioeconómicos bajos donde la pobreza, el hacinamiento, el limitado acceso a servicios básicos, entre otros factores, favorecen su transmisión. Asimismo, condiciones asociadas a los cambios climáticos y ambientales, la globalización del comercio y transporte de animales, favorecen el incremento del riesgo de transmisión de las zoonosis en el mundo.

La vigilancia de los daños de transmisión zoonótica en el Perú fue implementándose progresivamente a través de los años, es así que el ofidismo se vigila sistemáticamente desde el año 2000; sin embargo, se requiere estandarizar los procedimientos para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades zoonóticas y accidentes por animales ponzoñosos, así como para la vigilancia, comunicación y notificación de epizootias.

Los accidentes por animales ponzoñosos son producidos por la exposición (mordedura, picadura, contacto) a serpientes, arácnidos y otros que al inocular sus toxinas en el organismo provocan una serie de alteraciones fisiopatológicas que dan lugar a signos y síntomas, íntimamente relacionados con el género del animal agresor.

El **ofidismo** es un problema de singular importancia en las regiones rurales selváticas del país y en las zonas desérticas y semidesérticas de la costa norte y central.

Los accidentes producidos por serpientes venenosas en el Perú representan importantes pérdidas en el medio rural, sobre todo en áreas poco exploradas dentro de las que tenemos los nuevos asentamientos humanos en espacios rurales con fines agrícolas, exploraciones petrolíferas, mineras, forestales, pesca, caza turística.

El **ofidismo** es un accidente provocado por el veneno inoculado por la mordedura de una serpiente venenosa.

La Red de Salud Chachapoyas, realiza la Vigilancia Epidemiológica de este daño, a través de la notificación semanal como vigilancia de tipo

pasiva, notificando hasta la Semana Epidemiológica **(SE 25)** un total de **03 casos de mordedura por serpiente,** con una **IA 1.74 x 100 000 habitantes.** ***(Ver Tabla N° 19);*** procedentes de la provincia de Rodríguez de Mendoza, de los distritos de San Nicolás, Chirimoto y Limabamba. ***(Ver Tabla N° 20 y N° 21)***

Según el curso de vida, los grupos de edad más afectados durante la presente Semana Epidemiológica **(SE 25)** corresponde a los jóvenes de 18 a 29 años con el 67% (02/03), seguido de los adolescentes de 12 a 17 años con el 33% (01/03) del total de los casos notificados. ***(Ver Gráfico N° 30)***

El 100% de las víctimas de ofidismo corresponde al sexo masculino (03/03) y no se registran casos en el sexo femenino. ***(Ver Gráfico N° 31)***

Según el gráfico de tendencias, se observa una disminución del 33.33% (01 caso) en comparación con los casos reportados en el mismo periodo del año 2025. ***(Ver Gráfico N° 32)***

Según el último decenio los casos de mordedura por serpiente muestran un comportamiento oscilante, donde el mayor número de casos presentados fue en el 2021 con la notificación de 21 casos, asimismo la incidencia fue la más alta en referencia a los demás años del último decenio. ***(Ver Gráfico N° 33)***

Tabla N° 19. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Ofidismo y TIA. Años 2021- 2026*

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos	11	3	6	5	4	3
IA x 100 Mil Hab.	6.39	1.75	3.47	2.91	2.33	1.74
Defunciones	0	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 20. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Ofidismo, Según Provincias. Años 2021 - 2026*

PROVINCIA	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONGARA	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
CHACHAPOYAS	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
RODRIGUEZ DE MENDOZA	18	7	6	9	7	3	9	2	4	3	4	3
UTCUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	21	8	8	11	9	3	0	3	6	5	4	3

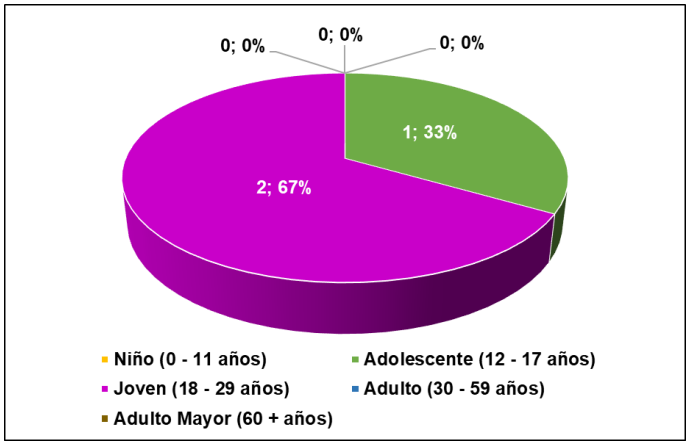
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 21. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Ofidismo, Según Distritos. Años 2021 - 2026*

Distritos	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
SAN NICOLAS	3	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	1
OMIA	2	5	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
CHIRIMOTO	7	2	0	0	2	1	4	2	0	0	2	1
LIMABAMBA	4	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1
HUAMBO	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
LA JALCA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
FLORIDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARISCAL BENAVIDES	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
MILPUCC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHUQUIBAMBA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUISPES	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEIMEBAMBA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
YAMBRASBAMBA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
SANTA CATALINA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
MOLINOPAMPA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PISUQUIA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Total general	21	8	8	11	9	3	11	3	6	5	4	3

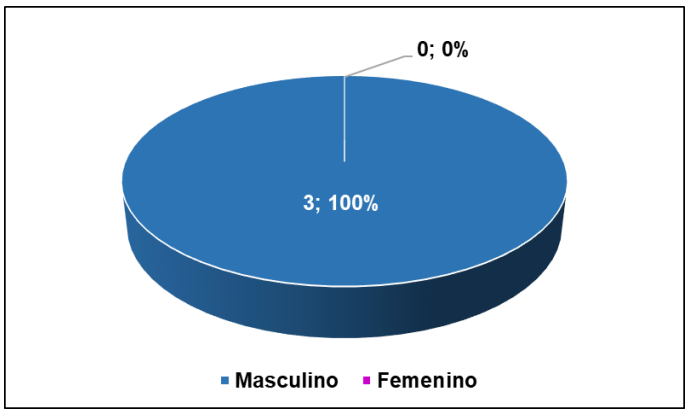
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 30. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos y Porcentaje de Ofidismo, Según Curso de Vida. Año 2026*



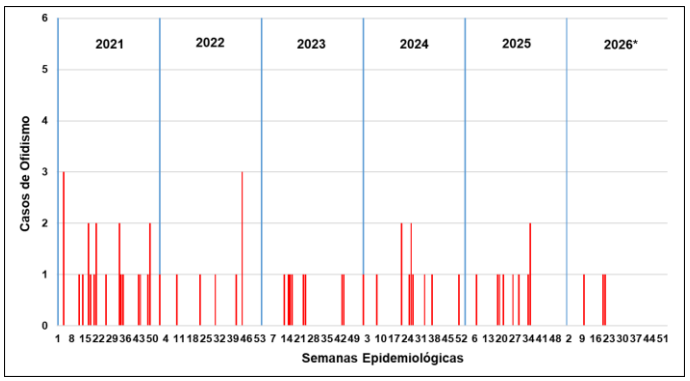
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 31. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Ofidismo, Según Sexo. Año 2026*



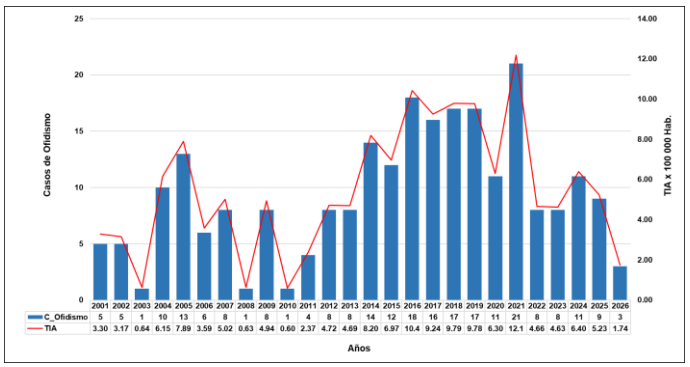
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 32. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de casos de Ofidismo. Años 2021 - 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 33. Red de Salud Chachapoyas: Evolución de los casos de Ofidismo y TIA. Años 2001 - 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES:

Situación Epidemiológica de Diabetes:

Caso de diabetes: Se denomina así a la persona de cualquier edad, con diagnóstico de diabetes por un profesional médico en base a criterios clínicos (poliuria, polifagia y polidipsia), con test de glicemia en plasma tomada en ayunas de 126 mg/dL o superior, o con un test de glicemia en cualquier hora del día de 200mg/dl o superior. Aquel que fue diagnosticado previamente como diabético y recibe tratamiento hipoglicemiante, aunque tenga un test de glicemia menor de 126 mg/dL, se considera un caso de diabetes.

Caso nuevo o incidente: Se refiere a la persona con diabetes que es diagnosticado por primera vez, y que anteriormente desconocía su condición de diabético. No tiene historia previa de tratamiento para la diabetes.

Caso prevalente: Se refiere a la persona con diabetes que ha sido diagnosticado previamente por un profesional médico en un servicio de salud, mediante un test de glicemia o una prueba de tolerancia a la glucosa, sin importar que el paciente haya iniciado o no el tratamiento correspondiente.

Tabla 2. Categorías de valores de glicemia en ayunas y del Test de tolerancia a la glucosa.

Diagnóstico metabólico	Glucosa Plasmática	
	Ayunas	2 horas post carga de Glucosa
Normal	<100	<140
GAA	100 a 125	<140
TGA	<100	140 a 199
GAA+TGA	100 a 125	140 a 199
Diabetes	≥126	≥200

Tomado de ALAD.

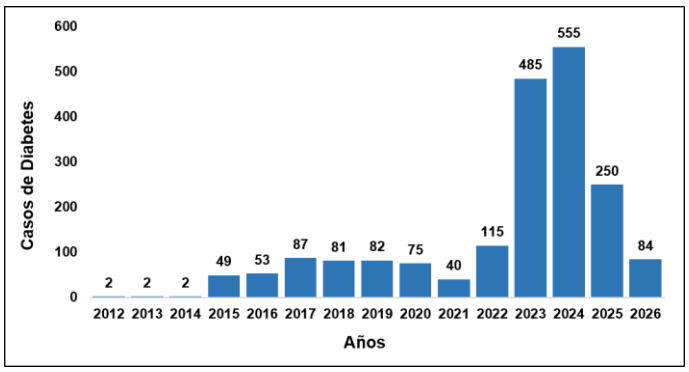
En la Red de Salud Chachapoyas, hasta la Semana Epidemiológica **(SE 25),** se han notificado al sistema de vigilancia un total de 84 casos de diabetes mellitus. Del total de casos reportados, el 63% (53/84) corresponde a casos prevalentes, mientras que el 37% (31/84) restante corresponde a casos nuevos. ***(Ver Gráfico N° 34 y N° 35)***

El 99% (83/84) de los casos registrados de diabetes corresponde a diabetes tipo 2, el 1% (01/84) a diabetes tipo 1 y el 0% (00/84) a diabetes gestacional. En relación con el tipo de caso, se observa que 52 corresponden a casos prevalentes de diabetes tipo 2 y 01 a diabetes tipo 1; mientras que 31 casos corresponden a casos nuevos de diabetes tipo 2. ***(Ver Gráfico N° 36 y N° 37)***

En la Red Integrada de Salud Chachapoyas, hasta la **SE 25-2026*,** se observa que la mayoría de los casos de diabetes se concentran en los grupos de edad de 30 a 59 años (46/84), de 60 años a más (35/84) y de 18 a 29 años (03/84). Asimismo, el 63% (53/84) de los casos registrados corresponde al sexo femenino, mientras que el 37% (31/84) corresponde al sexo masculino. Estos datos indican que la prevalencia de la diabetes es mayor en la población adulta y adulta mayor, especialmente en mujeres. ***(Ver Tabla N° 22 y Gráfico N° 38)***

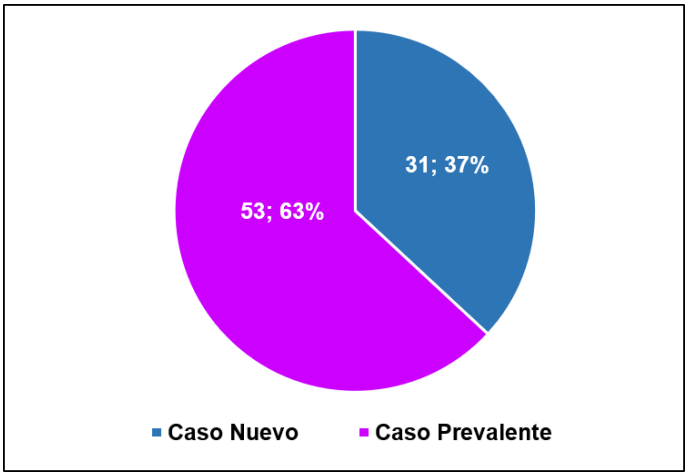
El 58% (49/84) de los casos notificados presenta alguna comorbilidad, mientras que el 42% (35/84) no presenta comorbilidades. Las comorbilidades reportadas con mayor frecuencia fueron la hipertensión arterial, la obesidad, la dislipidemia e hígado graso. ***(Ver Gráfico N° 39 y N° 40)***

Gráfico N° 34. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Evolución de los casos de Diabetes. Años 2012 – 2026*



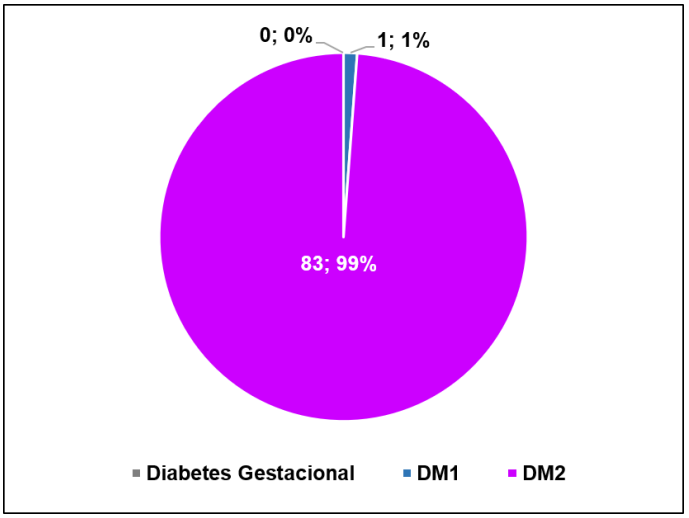
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 35. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Diabetes, Según Tipo de Caso. Año 2026*



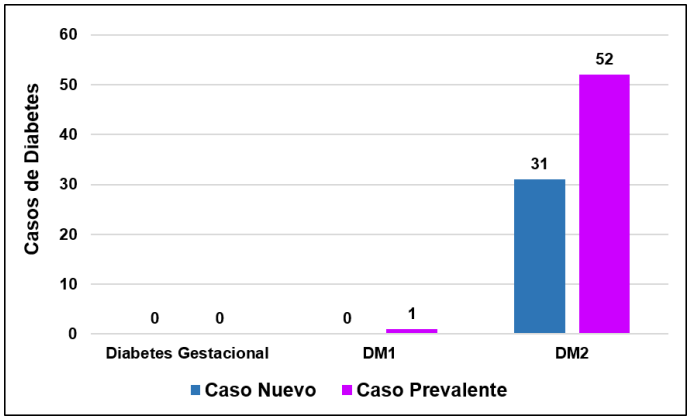
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 36. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Diabetes, Según Tipo de Diabetes. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 37. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Diabetes, Según Tipo de Caso y Tipo de Diabetes. Año 2026*



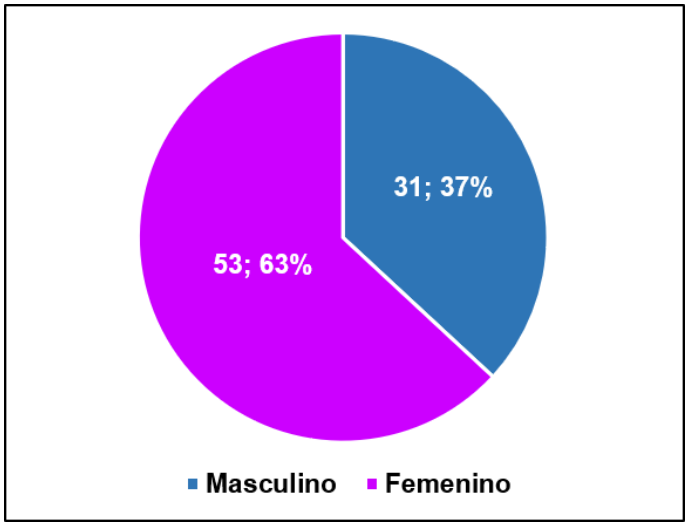
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 22. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Según Curso de Vida. Año 2026*

Curso de vida	Total	%	Sexo			
			Masculino	%	Femenino	%
(0 - 11) Adolescente	0	0.00	0	0.00	0	0.00
(12 - 17 años) Adolescente	0	0.00	0	0.00	0	0.00
(18 - 29 años) Joven	3	3.57	1	3.23	2	3.77
(30 - 59 años) Adulto	46	54.76	20	64.52	26	49.06
(60 + años) Adulto Mayor	35	41.67	10	32.26	25	47.17
Total	84	100.00	31	100.00	53	100.00

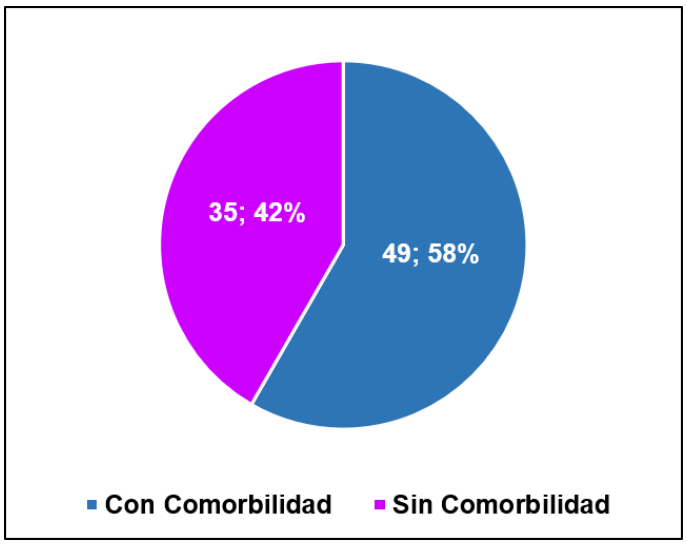
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 38. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Diabetes, Según Sexo. Año 2026*



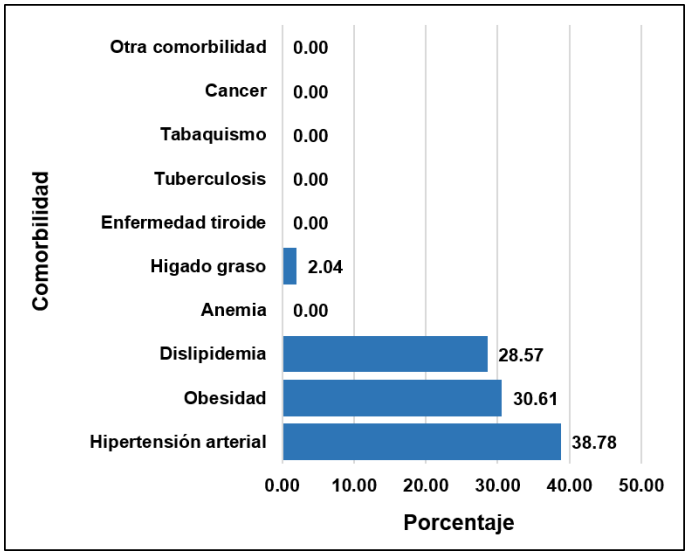
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 39. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Diabetes, con alguna Comorbilidad. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 40. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Diabetes, Según Tipo de Comorbilidad. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

OTRAS ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

Situación Epidemiológica de Riesgo de Exposición e Intoxicación Por Metales Pesados, Metaloides, Plaguicidas y Otras Sustancias Toxicas:

Los **plaguicidas** son sustancias ampliamente utilizadas en el mundo para el control de diferentes agentes, entre los que se encuentran insectos, artrópodos, animales transmisores de enfermedades, hongos y especies vegetales. Estos productos se utilizan en la agricultura (control de insectos y malezas); en la ganadería (control de parásitos); en el control de roedores y vectores transmisores de enfermedades como los mosquitos.

Son sustancias comercializadas en todo el mundo y utilizadas tanto de forma industrial como doméstica. En algunos casos, el contacto con plaguicidas tiene como consecuencia las intoxicaciones que se dan bien sea por uso inapropiado, de forma accidental (niños, por ejemplo) o incluso de manera delictiva y homicida.

Los **plaguicidas** se pueden clasificar de acuerdo con su uso, su estructura química o su toxicidad; sin embargo, la orientación terapéutica para los casos de intoxicación se enfoca en su estructura química. Todos los plaguicidas no se manejan de la misma manera, ni tienen las mismas implicaciones clínicas; algunos son extremadamente tóxicos y no se dispone de un antídoto específico para su manejo, otros son de baja toxicidad y son escasos los efectos tóxicos en el organismo. Es importante comprender la implicación que tienen las intoxicaciones agudas por plaguicidas (IAP) para su identificación y manejo.

Tóxico es toda sustancia capaz de producir algún daño en la estructura o función de un organismo afectándolo de forma local o sistémica, e intoxicación se entiende como un conjunto de alteraciones fisiológicas o anatomopatológicas producidas por la absorción de tóxicos, con diferente grado de gravedad clínica, la cual depende de diferentes variables de la sustancia y del individuo.

En el país se ha presentado un aumento importante en el uso de plaguicidas por la expansión de la ganadería, la agricultura y el uso en cultivos como el algodón, el plátano, la caña o las flores entre otros, o en el control de malezas, parásitos, roedores y vectores fundamentalmente; también se ha presentado un aumento en la cantidad de casos de intoxicación, los cuales se pueden clasificar de diferentes maneras.

Las **intoxicaciones agudas por plaguicidas (IAP)**, son una de las principales causas de muerte por intoxicaciones en el mundo, sin embargo, el sub-registro de este tipo de eventos aún es importante. Cada año, nuevos productos para el control de plagas y malezas salen al mercado y su uso se formula específicamente para cada producto o para múltiples productos según los requerimientos de quien los utilice.

En el mundo, la creciente tendencia de consumo de plaguicidas se refleja en las estadísticas presentadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el consumo de estas sustancias y de las intoxicaciones que causan.

En la Red de Salud Chachapoyas la vigilancia se está implementando de manera progresiva, teniendo en cuenta los distritos o lugares con mayor riesgo para ambas intoxicaciones; mayormente se notifican casos de **intoxicación por plaguicidas,** notificándose hasta la Semana Epidemiológica **(SE 25) 05 casos,** con una **IA 2.91 x 100 000 habitantes.** No reportándose defunciones hasta la fecha. ***(Ver Tabla N° 23)***

Al comparar los casos notificados por provincia, Chachapoyas concentra el 60% (03/05) del total, mientras que Luya representa el 40% (02/05). A nivel distrital, La Jalca registra el 40% (02/05), constituyéndose como el distrito con mayor número de notificaciones. Por su parte Leymebamba, San Jerónimo y Luya concentran cada uno el 20% (01/05), del total de casos registrados. ***(Ver Tabla N° 24 y N° 25)***

Según el curso de vida, hasta la Semana Epidemiológica **(SE 25),** el grupo etario más afectado fue el de adultos de 30 a 59 años, que concentró el 60% (03/05) del total de casos notificados. Por su parte, los jóvenes de 18 a 29 años y los adultos mayores de 60 años a más registraron el 20% (01/05) cada uno. ***(Ver Gráfico N° 41)***

Con respecto al género, el 80% de los casos (04/05) corresponde al sexo masculino y el 20% (01/05) al sexo femenino. ***(Ver Gráfico N° 42)***

Según el análisis de la tendencia epidemiológica, durante el período evaluado se evidencia una disminución del 37.5% (03 casos) en el número de casos, en comparación con el mismo período del año 2025. ***(Ver Gráfico N° 43)***

Según el último decenio, los casos de intoxicación por plaguicidas muestran un comportamiento oscilante. El mayor número de casos se registró en el año 2017, con 23 notificaciones, lo que evidencia una mayor sensibilidad en su reporte; asimismo, la incidencia fue la más alta en comparación con los demás años del periodo. ***(Ver Gráfico N° 44)***

Tabla N° 23. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Intoxicación por Plaguicidas y TIA. Años 2021 – 2026*

AÑOS	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Casos	3	5	6	6	8	5
IA x 100 Mil Hab.	1.74	2.91	3.47	3.49	4.65	2.91
Defunciones	3	2	1	0	0	0
Letalidad x 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 24. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Intoxicación por Plaguicidas, Según Provincias. Años 2021 - 2026*

PROVINCIA	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONGARA	0	3	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
CHACHAPOYAS	1	4	6	7	7	3	1	3	4	6	4	3
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	3	3	4	0	6	2	2	0	2	0	4	2
RODRIGUEZ DE MENDOZA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTCUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	4	10	11	7	14	5	3	5	6	6	8	5

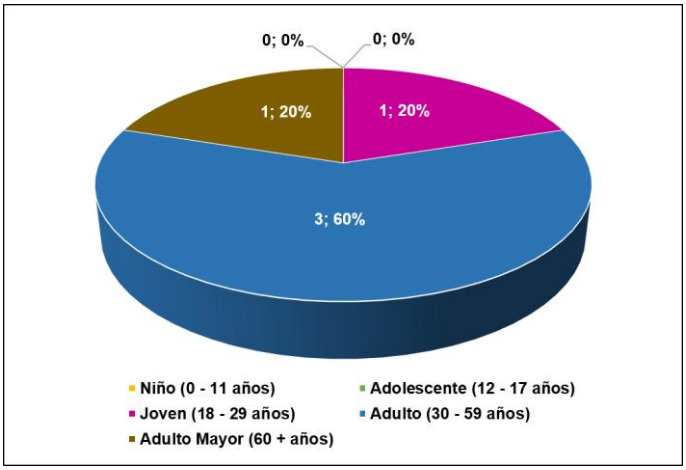
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 25. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Intoxicación por Plaguicidas, Según Distritos. Años 2021 - 2026*

DISTRITOS	Casos Acumulados						Corte a la S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
CHACHAPOYAS	0	1	3	3	5	0	0	1	1	3	3	0
LEIMEBAMBA	0	0	1	3	1	1	0	0	1	3	1	1
LA JALCA	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2
SAN JERONIMO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
PISUQUIA	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
LUYA	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
MOLINOPAMPA	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
SAN FRANCISCO DE YESO	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TRITA	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
OCUMAL	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
TINGO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONTEVIDEO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
CUISPES	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALERA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
BALSAS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHUQUIBAMBA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
CHIRIMOTO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LONYA CHICO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMPORREDONDO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHILIQUIN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
OCALLI	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
FLORIDA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
COCABAMBA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JAZAN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
LEVANTO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Total general	4	10	11	7	14	5	3	5	6	6	8	5

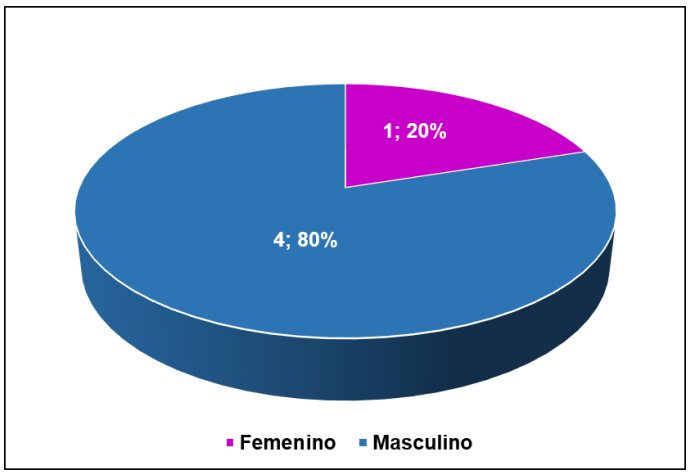
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 41. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos y Porcentaje de Intoxicación por Plaguicidas, Según Curso de Vida. Año 2026*



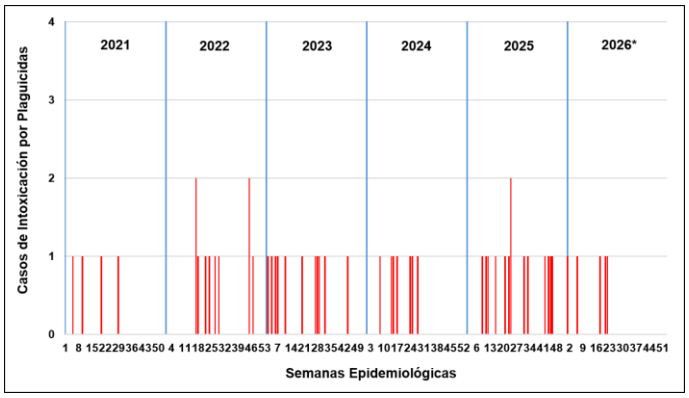
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 42. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Casos de Intoxicación por Plaguicidas, Según Sexo. Año 2024*



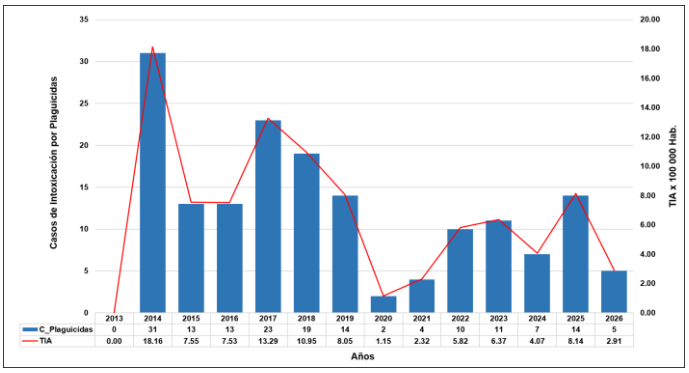
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 43. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de Casos de Intoxicación por Plaguicidas. Años 2021 - 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 44. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Evolución de los casos de Intoxicación por Plaguicidas y TIA. Años 2013 - 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA) EN LA RED INTEGRADA DE SALUD CHACHAPOYAS HASTA LA SE 25 – 2026*

Las enfermedades diarreicas agudas continúan siendo una causa importante de morbilidad en la niñez en nuestra región, además son enfermedades prevenibles relacionadas al menor acceso a servicio de agua potable, menor acceso a eliminación adecuada de excretas, así como a la práctica de hábitos inadecuados de higiene.

La Red de Salud Chachapoyas, hasta la Semana Epidemiológica **(SE 25)** del año 2026, ha notificado un total de 4423 episodios de EDA, de los cuales 4412 son autóctonos. Del total, el 29.85% corresponde a menores de 5 años, con una razón de 112.47 episodios por cada 1,000 menores de 5 años; mientras que el 70.15% afectó a personas de 5 años a más, con una razón de 19.30 episodios por cada 1,000 habitantes de este grupo etario. Asimismo, se reportaron 81 hospitalizaciones por EDA, con una razón de 1.84 hospitalizados por cada 100 episodios, siendo esta mayor en el grupo de menores de 5 años en comparación con el de 5 años a más. Finalmente, en el año 2026 se registró una defunción. ***(VerTabla N° 26)***

El promedio de episodios de EDA notificados por semana epidemiológica (SE) en el año 2026, hasta la SE 25, fue de 176; cifra que representa una disminución del 9.28% en comparación con el año 2025, cuando se registraron 194 episodios por SE. A nivel de la Red de Salud Chachapoyas, se observa una tendencia oscilante de los episodios de EDA desde el inicio de 2026 hasta la SE 13, con un incremento significativo en la notificación durante las últimas semanas. ***(Ver Gráfico N° 45 y N° 46)***

La razón de episodios de EDA en el año 2026 fue de 25.64 episodios por cada 1,000 habitantes, registrándose la mayor cantidad de casos en las provincias de Chachapoyas y Luya. ***(VerTabla N° 27 y N° 28)***

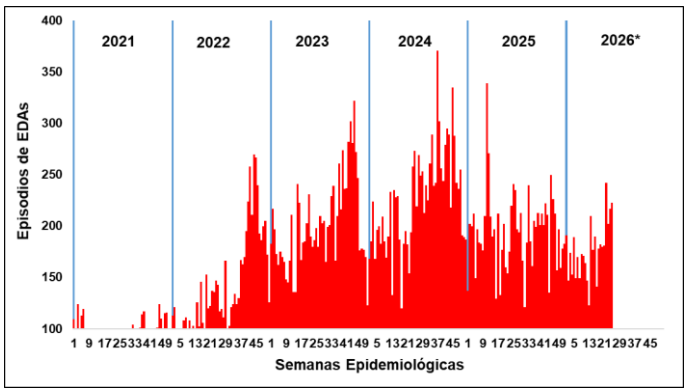
Según el canal endémico, los episodios de EDAs se encuentran en la **Zona de Epidemia;** zona que representa el 28% (07/25) del total de semanas epidemiológicas reportadas; de la misma manera los episodios de EDAs acuosas también se encuentran en la **Zona de Epidemia,** a diferencia los episodios de EDAs disentéricas para esta SE se encuentran en la **Zona de Éxito.** (***Ver Gráfico N° 47, N° 48 y N° 49***)

Tabla N° 26: Red Integrada de Salud Chachapoyas: Indicadores de las Enfermedades Diarreicas Agudas por Grupos de Edad. Años 2024 – 2026*

INDICADOR	EDAD	2024	2025	2026*
EPISODIOS	< 5 Años	3317	2772	1317
	> 5 Años	8384	7461	3095
	Total	**11701**	**10233**	**4412**
	Acuosa	11608	10184	4394
	Disenterica	93	49	18
Incidencia Acumulada x 1000 Hab	< 5 Años	254.90	217.41	112.47
	> 5 Años	52.78	46.87	19.30
	Total	**68.08**	**59.52**	**25.64**
Hospitalizaciones	< 5 Años	28	18	30
	> 5 Años	93	27	51
	Total	**121**	**45**	**81**
Tasa de Hospitalizaciones x 100 episodios	< 5 Años	0.84	0.65	2.28
	> 5 Años	1.11	0.36	1.65
	Total	**1.03**	**0.44**	**1.84**
Defunciones	< 5 Años	0	0	0
	> 5 Años	0	0	1
	Total	**0**	**0**	**1**
Tasa de mortalidad x 100 episodios	< 5 Años	0.00	0.00	0.00
	> 5 Años	0.00	0.00	0.03
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.02**

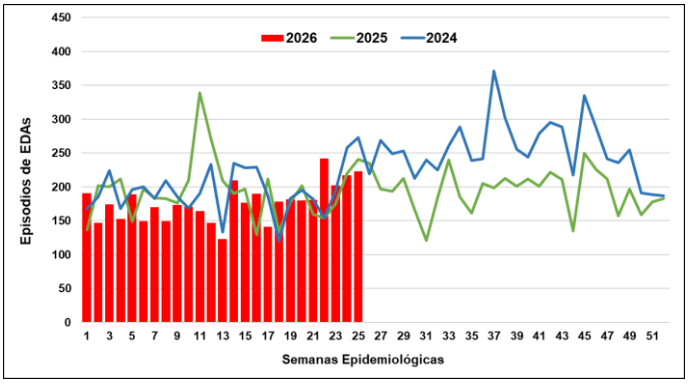
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 45. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de las Enfermedades Diarreicas Agudas. Años 2021 - 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 46. Red de Salud Chachapoyas: Episodios de las Enfermedades Diarreicas Agudas por Semana Epidemiológica. Años 2024- 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 27. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Episodios de Enfermedades Diarreicas Agudas y TIA. Años 2021 – 2026*

Años	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Episodios	2085	2834	4565	4842	4859	4412
Incidencia por Mil Hab.	12.11	16.51	26.43	28.17	28.26	25.64
Defunciones	0	0	0	0	0	1

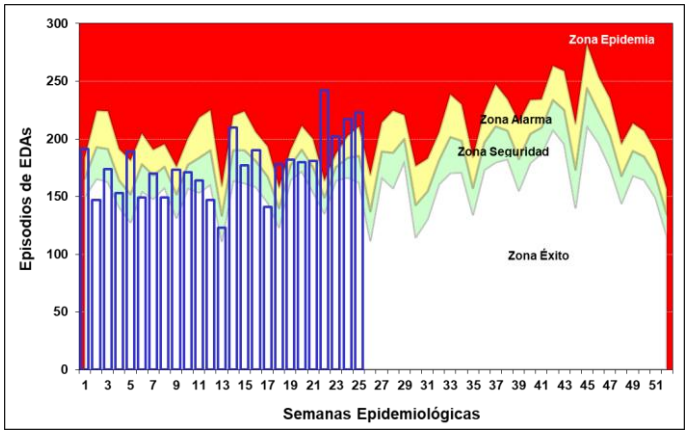
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 28: Red Integrada de Salud Chachapoyas: Episodios de las Enfermedades Diarreicas Agudas, Según Provincias. Años 2021 – 2026*

Provincias	AÑOS						Corte S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONGARA	602	919	1223	1535	1614	564	227	373	491	645	819	564
CHACHAPOYAS	1512	3136	4786	5265	4163	2052	801	1090	2117	2186	1960	2052
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	1714	2220	2991	3453	3157	1306	771	853	1430	1393	1509	1306
RODRIGUEZ DE MENDOZA	645	1096	1526	1448	1299	490	286	518	527	618	571	490
UTCUBAMBA	28	58	7	56	3	11	17	22	7	39	0	11
Total general	**4501**	**7432**	**10533**	**11757**	**10236**	**4423**	**2102**	**2856**	**4572**	**4881**	**4859**	**4423**

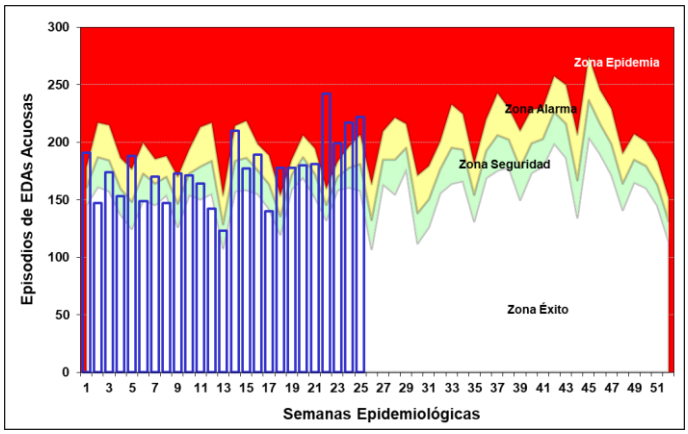
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 47. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Canal Endémico de las Enfermedades Diarreicas Agudas. Año 2026*



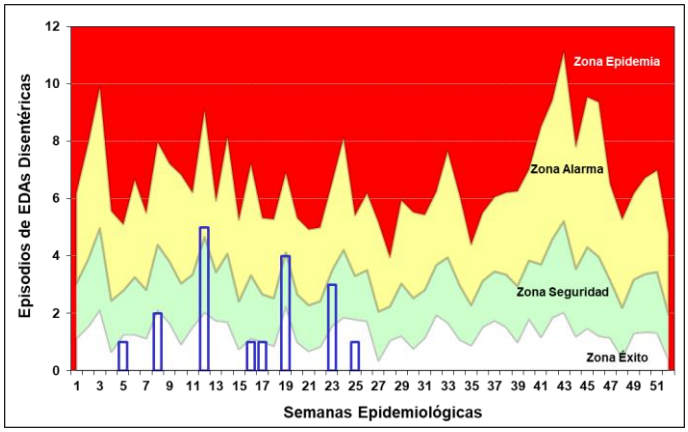
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 48. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Canal Endémico de las Enfermedades Diarreicas Agudas Acuosas. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 49. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Canal Endémico de las Enfermedades Diarreicas Agudas Disentéricas. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA), NEUMONÍAS Y SOB (ASMA) EN LA RED INTEGRADA DE SALUD CHACHAPOYAS HASTA LA SE 25 - 2026*

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen una importante causa de morbimortalidad, fundamentalmente entre los niños menores de 5 años, las personas mayores de 65 años y aquellas que presentan ciertas condiciones que aumentan el riesgo para desarrollar complicaciones que pueden derivar en formas graves. Existen factores que favorecen una mayor incidencia de IRA como: bajo peso al nacer, malnutrición (principalmente en niños), la polución atmosférica, hacinamiento en el hogar, los bajos niveles de inmunización y el nivel de pobreza, son condiciones que se encuentran aún latentes en parte de nuestro país.

El Centro Nacional de Epidemiología de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, realiza la vigilancia epidemiológica de la tendencia y el comportamiento de las IRA desde 1999, a través de la Directiva N° 001- DGSP/SUBPCIRA-02/99, la Directiva sanitaria N° 046- MINSA/DGE-V.01 con R.M. N° 506-2012/MINSA del 18 de junio de 2012, que es actualizada con la Directiva Sanitaria N° 061-MINSA/DGE-V.01 con R.M. N° 1024-2014/MINSA del 31 de Diciembre de 2014, que norma la notificación de las IRA, neumonías y defunciones por neumonía, con prioridad en los grupos de riesgo: menores de 5 años y de 60 años a más a nivel nacional, en forma colectiva.

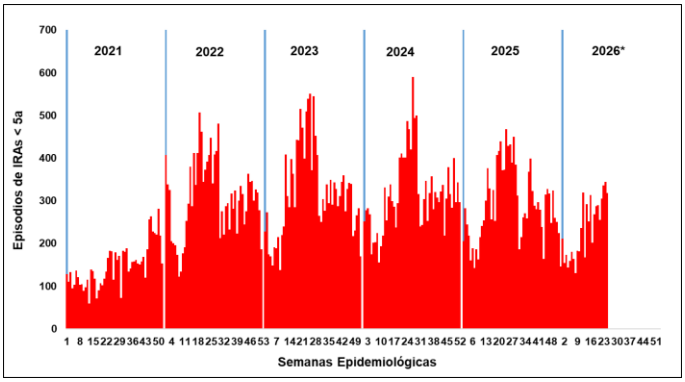
La coordinación de Epidemiología de la Red de Salud Chachapoyas, es responsable de la vigilancia epidemiológica de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y Neumonías, dicha notificación se realizan de forma semanal y consolidada, los datos son recolectados según grupo de edad, semana epidemiológica y distrito de procedencia. La notificación de las defunciones por neumonía en menores de 5 años es individual y consolidada, con el objetivo de conocer mejor los factores de riesgo para la orientación de las intervenciones preventivas.

En lo que va del año 2026, desde la SE 01 hasta la SE 25, se observa una tendencia oscilante en los episodios de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años, con un aumento significativo en la notificación durante la semana 12, 16, 22, 23, 24 y 25. **(Ver Gráfico N° 50 y N° 51)** Se ha notificado un total de 5870 episodios de IRA, siendo de origen autóctono, 5868 episodios con una razón de 5011.10 episodios por cada 10 000 menores de 5 años. **(Tabla N° 29)**

Por otro lado, se observa que la mayor cantidad de episodios de IRA proviene de las provincias de Chachapoyas y Luya, dentro de la jurisdicción de la Red Integrada de Salud Chachapoyas. ***(Ver Tabla N° 30)***

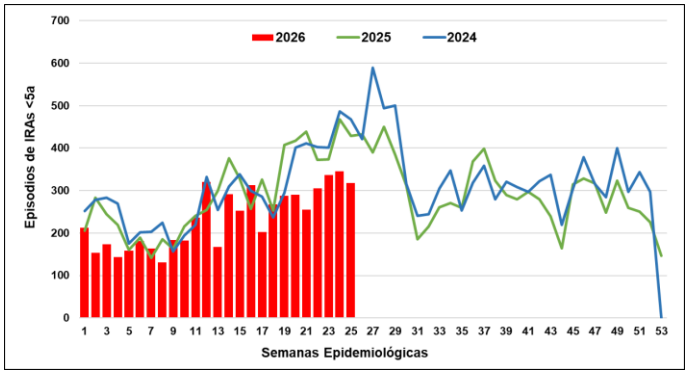
Según el canal endémico, los episodios de IRA se encuentran en la **Zona de Éxito;** zona que representa el 80% (20/25) del total de semanas epidemiológicas reportadas. ***(Ver Gráfico N° 52)***

Gráfico N° 50. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Tendencia de las Infecciones Respiratorias Agudas en Niños < 5 Años. Años 2021 - 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 51. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Episodios de las Infecciones Respiratorias Agudas en Niños < 5 Años por Semana Epidemiológica. Años 2024- 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 29. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Episodios de Infecciones Respiratorias Agudas y TIA. Años 2021 – 2026*

Años	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N° de Episodios	2934	7764	8098	7370	7248	5868
TIA x 10 Mil Hab.	1901.49	5411.21	6069.55	5663.57	5684.71	5011.10

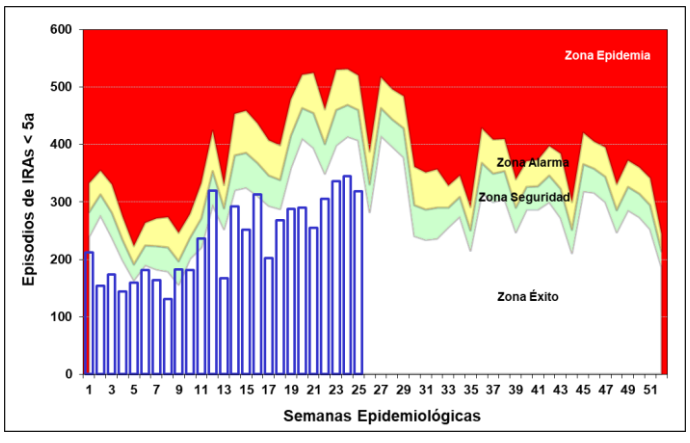
Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Tabla N° 30: Red Integrada de Salud Chachapoyas: Episodios, Razón, Defunciones y Letalidad de Infecciones Respiratorias Agudas en Niños < 5 Años, Según Provincias. Año 2026*

Provincias	ANOS						Corte S.E. 25*					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
BAGUA	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONGARA	1232	2766	2714	2563	2541	924	448	1355	1373	1256	1242	924
CHACHAPOYAS	2157	5342	5629	5390	4822	1794	835	2744	3044	2722	2435	1794
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUYA	3099	5286	5112	5941	5727	2266	1215	2738	2626	2663	2885	2266
RODRIGUEZ DE MENDOZA	1226	2584	3213	2566	2367	884	551	1267	1427	1150	1118	884
UTCUBAMBA	15	43	12	8	4	2	7	18	12	6	0	2
Total general	7729	16035	16680	16466	15461	5870	3056	8122	8482	7797	7680	5870

Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

Gráfico N° 52. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Canal Endémico de las Infecciones Respiratorias Agudas en Niños < 5 Años. Año 2026*



Fuente: Sistema de registro, notificación procesamiento y actualización de datos de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica – Red Integrada de Salud Chachapoyas a la *S.E. 25.

INDICADORES DE MONITOREO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 25 - AÑO 2026*

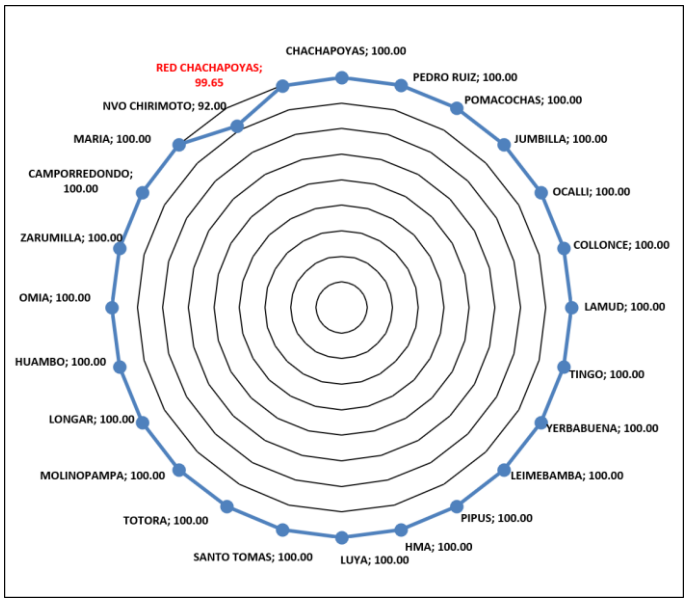
Los indicadores de monitoreo contribuyen a mejorar la información semanal para que esta sea oportuna y de calidad y así el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, de la Red de Salud Chachapoyas tenga un procesamiento y análisis de datos válidos para la toma de decisiones en la prevención y control de los daños sujetos a vigilancia en salud pública. Teniendo como criterios de calificación para los Indicadores de Monitoreo: **DEBIL, REGULAR, BUENO Y OPTIMO.**

Estratos Nacional					
OPORTUNIDAD	COBERTURA	CALIDAD DEL DATO	RETROALIMENTACIÓN	Puntaje Total	
1. 100%	1. 100%	1. 95 - 100%	1. 90 - 100%	A. 90% - 100%	Óptimo
2. 95 - 99.9%	2. 80 - 99.9%	2. 90 - 94.9%	2. 80 - 89.9%	B. 80% - 90%	Bueno
3. 90 - 94.9%	3. 60 - 79.9%	3. 85 - 89.9%	3. 70 - 79.9%	C. 70% - 80%	Regular
4. Menos de 90%	4. Menos de 60%	4. Menos de 85%	4. Menos de 70%	D. Menos de 70%	Débil

Indicador de Oportunidad:

En el indicador de Oportunidad a la SE 25 del año 2026, la Red Integrada de Salud Chachapoyas obtiene una calificación BUENO (99.65%), de la misma manera las 21 Microrredes y el Hospital María Auxiliadora obtuvieron una calificación ÓPTIMO (100%); sin embargo, la Microrred Nuevo Chirimoto obtuvo una calificación BUENO (92.00%). ***(Ver Gráfico N° 53)***

Gráfico N° 53. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Oportunidad de la Notificación. Año 2026*

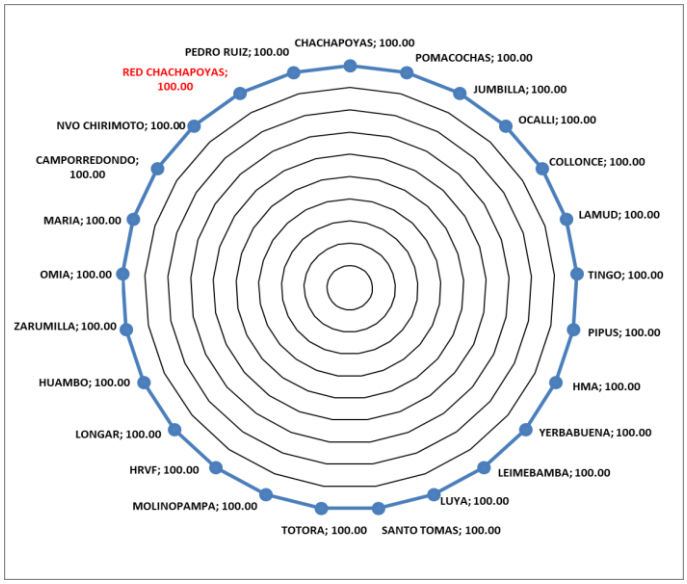


Fuente: Unidad Técnica de Notificación – Red de Salud Chachapoyas - DIRESA AMAZONAS a la *S.E. 25.

Indicador de Cobertura:

En el indicador de Cobertura a la SE 25 del año 2026, la Red Integrada de Salud Chachapoyas obtiene una calificación ÓPTIMO (100%), de la misma manera las 22 Microrredes y el Hospital María Auxiliadora obtuvieron una calificación ÓPTIMO (100%). ***(Ver Gráfico N° 54)***

Gráfico N° 54. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Cobertura de la Notificación. Año 2026*

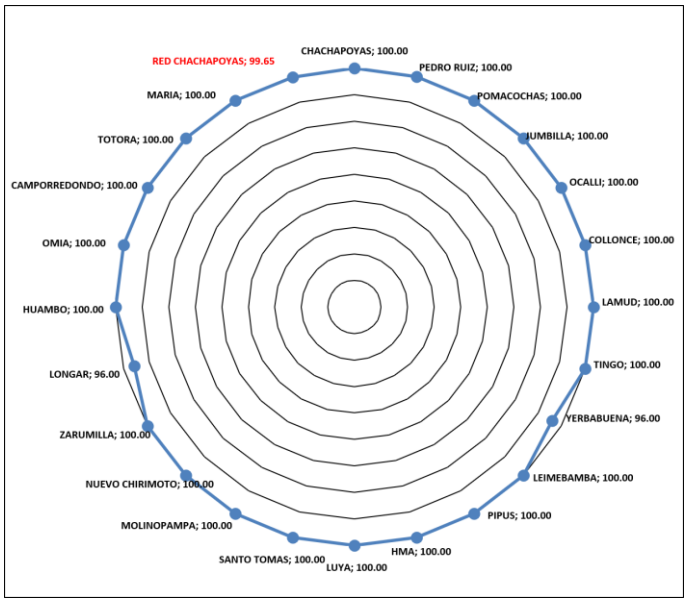


Fuente: Unidad Técnica de Notificación – Red de Salud Chachapoyas - DIRESA AMAZONAS a la *S.E. 25.

Indicador de Calidad del Dato:

En el indicador de Calidad del Dato a la SE 25 del año 2026, la Red Integrada de Salud Chachapoyas obtiene una calificación ÓPTIMO (99.65%), de la misma manera 20 Microrredes y el Hospital María Auxiliadora obtuvieron una calificación ÓPTIMO (100%); sin embargo, la Microrred Longar y Yerbabuena obtuvieron una calificación ÓPTIMO (96.00%). ***(Ver Gráfico N° 55)***

Gráfico N° 55. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Calidad del Dato. Año 2026*

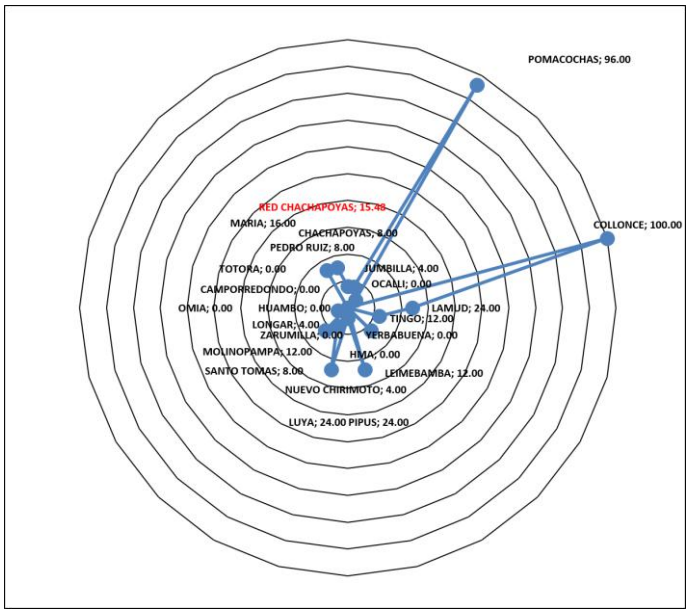


Fuente: Unidad Técnica de Notificación – Red de Salud Chachapoyas - DIRESA AMAZONAS a la *S.E. 25.

Indicador de Retroalimentación:

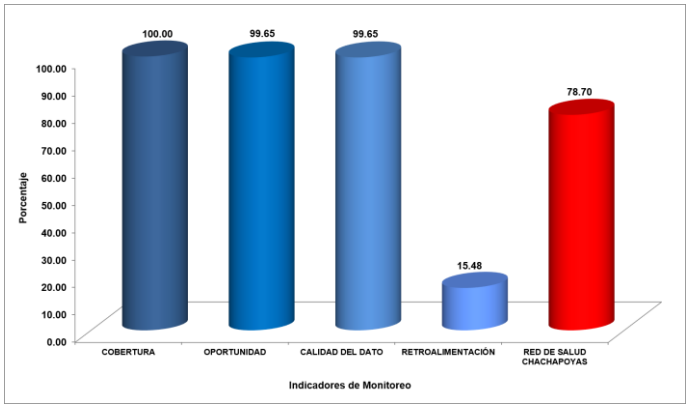
En el indicador de Retroalimentación a la SE 25 del año 2026, la Red Integrada de Salud Chachapoyas obtiene una calificación DÉBIL (<70%). La Microrred Collonce obtuvo una calificación ÓPTIMO (100%), la Microrred Pomacochas obtuvo una calificación ÓPTIMO (96.00%), sin embargo, las 20 Microrredes y el Hospital María Auxiliadora obtuvieron una calificación DÉBIL (<70%). ***(Ver Gráfico N° 56)***

Gráfico N° 56. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Retroalimentación. Año 2026*



Fuente: Unidad Técnica de Notificación – Red de Salud Chachapoyas - DIRESA AMAZONAS a la *S.E. 25.

Gráfico N° 57. Red Integrada de Salud Chachapoyas: Monitoreo de Indicadores del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Año 2026*



Fuente: Unidad Técnica de Notificación – Red de Salud Chachapoyas - DIRESA AMAZONAS a la *S.E. 25.